Skognitiv

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Ett konstnärligt projekt för

personer med demenssjukdomar

Benjamin Persson



Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Självständigt arbete i bild, 30 hp

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild och media)

VT26

Handledare (uppsats): Ebba Christina Blåvarg

Handledare (gestaltande arbete): Malin Pettersson Öberg

Examinator: Anette Göthlund

Defognitive - An artistic project for people with dementia

Abstract

I denna etnografiska studie har jag undersökt både hur personer med demens upplever att få teckna egna träd under en workshop, och hur en konstnärlig workshop för målgruppen kan organiseras. Samtidigt har jag också velat lyfta stigmat kring demens, och låta fler uttryck synas. Studien består av två delar: en uppsats som behandlar min arbetsprocess, och ett gestaltande arbete som ställts ut på Konstfacks vårutställning.

I min arbetsprocess har jag arrangerat workshops på två äldre- och demensboenden på Gotland, där totalt 14 personer med demens deltog. Under varje workshop har deltagarna fått teckna egna träd på A2-papper med hjälp av färgkritor, tuschpennor eller blyertspennor. På grund av medicinska skäl så skapade en deltagare en bild av färgade papperslappar istället. Varje workshop har jag dokumenterat med anteckningar, vilket har blivit en del av det empiriska materialet. Av mina totalt 14 deltagare så skapade 13 deltagare teckningar av träd, och teckningarna har blivit en annan del av det empiriska materialet. Empirin har sedan strukturerats upp i kategorier, och analyserats utifrån både ett relationellt pedagogiskt och ett sociokulturellt perspektiv. Träden som deltagarna har tecknat har jag sammanställt till ett större konstverk, i form av mitt gestaltande arbete. Verket består av både ett bildspel och collage där teckningarna sammanställts. Trots att min studie fokuserar på personer med demenssjukdomar så har jag i det gestaltande arbetet även tagit med bilder som anhöriga och personal på boendena har tecknat. Detta eftersom de anhöriga och personalen bidrog till att aktivera deltagarna, vilket var en viktig del i processen.

Från resultatet av min studie så har jag lärt mig att en bildpedagog för personer med demens bör vara anpassningsbar, lyhörd, och ta hänsyn till en stor variation av förutsättningar. Träd är också ett ämne som personer med demens kan ha personliga kopplingar till och kan avbilda tack vare träds enkla men varierande utformningar. Att ge deltagarna valmöjligheter i material är viktigt för att främja bildspråket. Och om bildpedagogen inte känner deltagarna på förhand så är det fördelaktigt om vårdpersonal kan vara behjälpliga med att samla och kommunicera med deltagarna. Jag hoppas att min studie kan användas för att arrangera konstnärliga vardagsaktiviteter för personer med demens, samt öka samhällets vetskap kring sjukdomarna. På ett rent pedagogiskt plan så hoppas jag även att studien kan användas i skolmiljöer, för att skapa workshops som är anpassade till elevers olika förutsättningar. Och likaså har jag förhoppningar om att min studie kan belysa trädets betydelse som tema i alla typer av konstnärliga workshops, oavsett målgrupp.

Nyckelord

Bildpedagogik; Demenssjukdomar; Workshops; Träd

Innehåll

1. Inledning **1**
2. Syfte och frågeställningar **2**
3. Bakgrund **2**
3.1 Konstnärliga aktiviteter och hälsa 2
3.2 Bildpedagogik och demenssjukdomar 3
3.3 Träd som motiv 4
3.4 Vad är demens? 5
3.5 Språkbruk och stigmatisering kring demens 6
4. Teoretiskt perspektiv **7**
4.1 Relationell pedagogisk teori 7
4.2 Sociokulturell teori 8
5. Tidigare forskning **9**
5.1 Konst, bildpedagogik och demens 9
5.2 Träd och demens 12
6. Metod och material **14**
6.1 Förberedelser 15
6.1.1 Material till workshop 15
6.1.2 Miljö och tidsram 16
6.2 Urval 17
6.3 Etik 17
6.3.1 Samtycke 18
6.3.2 Etik kring personer med demens 18
6.4 Empiri och material 19
6.5 Metod för analys 20
7. Resultat **20**
7.1 Arrangerandet 21
7.2 Engagemanget 22
7.3 Materialet 23
7.4 Trädens betydelse 24
8. Analys och tolkning **26**
8.1 Bildpedagogens roll 26
8.2 Vårdpersonalens roll 28
8.3 Materialets roll 29
8.4 Trädens roll 29
9. Gestaltande arbete **31**
10. Slutdiskussion **33**
11. Källförteckning **34**
11.1 Bilagor 38

1. Inledning

Demens är en typ av sjukdom som de allra flesta nog har hört talas om. Varje år drabbas nämligen närmare 10 miljoner människor i världen av någon typ av demenssjukdom, och det är även den sjunde mest förekommande dödsorsaken i världen.[1] Men trots den höga statistiken så finns det ett stigma mot demens, som ger upphov till många förutfattade meningar kring personerna som lever med sjukdomarna.[2] Jag har själv haft en viss uppfattning om demens, som har förändrats ju mer jag lärt mig om sjukdomarna och personerna som lever med dem.

År 2019 flyttade jag till Gotland för att ta paus från studierna. Jag sökte flera jobb, och fick till slut vikariat på ett hemtjänstföretag. Detta var helt nytt för mig, och jag hade ingen tidigare erfarenhet av vårdarbete. Mellan 2019–2021 jobbade jag inom hemtjänsten på Gotland, blev allt mer erfaren, och fick uppleva många livsöden och sjukdomar. Men det var en typ av sjukdom som verkligen gjorde ett intryck hos mig: demens. Tidigare hade jag förknippat demens med naturlig förvirring hos äldre människor. Men inom vårdarbetet fick jag se att det var betydligt mer komplext än så: demens kunde drabba många åldersgrupper, innebar mer än bara "naturlig förvirring", och inte minst, en stor oro och belastning för anhöriga. Hösten 2021 började jag studera på Konstfacks ämneslärarutbildning med inriktning bild-media, och under somrarna har jag haft diverse vikariat. Erfarenheterna inom hemtjänsten inspirerade mig att söka jobb på ett äldreboende sommaren 2025, där majoriteten av de boende hade någon typ av demens, vilket gav mig ännu närmare kontakt med sjukdomarna. Vid ett par tillfällen tecknade jag med några av de boende, och där upplevde jag ett engagemang och en livslust jag aldrig sett hos personerna innan.

Under min utbildning på Konstfack har målgruppen varit barn och tonåringar, då jag studerar till lärare mot gymnasienivå. Detta har gjort mig nyfiken på att upptäcka andra målgrupper, och jag har då sett möjligheterna kring personer med demens. Idén till min studie kommer då främst från mina erfarenheter inom vård och omsorg, där jag från att ha vetat väldigt lite om demens har lärt mig mycket om sjukdomarna under kort tid. Därför vill jag kombinera mina upplevelser kring demenssjukdomar med mina bildpedagogiska färdigheter, och göra en studie som ger personer som lever med demens en chans att låta deras konstnärliga uttryck synas.

Min idé är att deltagarna ska teckna egna träd, som jag sedan sammanställer till ett större konstverk. Idén har främst kommit från att träd har enkla men igenkännliga former, som ändå går att variera stort, och därför kan passa personer med nedsatta kognitiva förmågor. Det finns även forskning som bevisar att plantering av träd har positiv inverkan hos personer med

[1] World Health Organization, *Dementia*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia, 6 februari 2026.
[2] Lars Krister Hydén & Atiqur Rahman, "Dementism och ålderism", i *Perspektiv på ålderism*, redigerad av Håkan Jönson, Lund: Social Work Press, 2021; Dementia UK, *Dealing with the stigma of dementia*, https://www.dementiauk.org/information-and-support/living-with-dementia/dealing-with-stigma/, 8 april 2026.

demenssjukdomar. Mina deltagare kommer alltså få plantera en egen skog, med hjälp av konstens verktyg.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien formuleras från ett bildpedagogiskt perspektiv, och är dels att ta reda på hur personer med demenssjukdomar upplever att få teckna egna träd under en workshop, och dels att ta reda på hur en konstnärlig workshop för målgruppen kan organiseras. Jag kommer göra detta genom att arrangera workshops för personer med demens och låta dem teckna egna träd, som sedan sammanställs till mitt gestaltande arbete. Jag hoppas att studien kommer ge en ökad kunskap kring hur man bildpedagogiskt kan arbeta med personer med demens, och att ge personerna som lever med sjukdomarna en chans att synas.

Mina frågeställningar är: "Hur upplever personer med demens att få teckna egna träd under en workshop?*"* och "Hur kan en konstnärlig workshop för personer med demens organiseras?"

3. Bakgrund

I detta kapitel ger jag en bakgrund kring konst och dess effekter på människors hälsa, hur konst lärs ut åt personer med demens, och trädens betydelse inom konst. Sedan tar jag upp vad demens faktiskt är, vilka olika typer som finns, och hur förekommande det är. Kapitlet avslutas med språkbruket kring personer med demens, och stigmatiseringen av sjukdomarna.

3.1 Konstnärliga aktiviteter och hälsa

Konst är en viktig del av mänsklighetens historia och utveckling, och något som alltid hjälpt människor att ta sig igenom svåra stunder i livet, som WHO (FN:s fackorgan inriktat på global hälsa och sjukvård) beskriver det.[3] Genom att skapa och ta del av konst kan de positiva känslorna och förmågan för empati öka, vilket medför en drivkraft för bearbetning och återhämtning. WHO publicerade *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*, en forskningsrapport där Daisy Fancourt (docent och forskare inom epidemiologi och sjukvård) och Saoirse Finn (forskare inom epidemiologi och sjukvård) sammanfattar olika studier kring konst och dess effekter på människors hälsa.[4] Bland annat kan kulturellt engagemang (till exempel att besöka konserter eller museer) minska risken för nedsatta kognitiva förmågor.[5] De sociala aspekterna av konst hittas i form

[3] World Health Organization, *Arts and health*, https://www.who.int/initiatives/arts-and-health, 13 april 2026.

[4] Daisy Fancourt & Saoirse Finn, *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*, World Health Organization, 2019, https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/e1cc8536-773d-446f-9822-8ae376f41415/content.

[5] Ibid, sid. 24.

av gruppaktiviteter, och tenderar att minska stress och depression; inte minst för personer med demenssjukdomar.[6]

Alzheimer Society Saskatchewan (kanadensisk välgörenhetsorganisation inriktad på demens) beskriver i ett informationshäfte vikten av aktiviteter för personer med demens.[7] I häftet tas många förslag på aktiviteter upp, och flera har med bildämnet att göra, såsom att färglägga bilder, skapa fyrklövrar i papper, och måla påskägg. Häftet påpekar också att en person med demenssjukdom är i ett föränderligt stadie, och kan därför gradvis tappa förmågan att utföra vissa aktiviteter. Detta innebär dock inte att aktiviteterna blir mindre viktiga, utan stärker personens känslor av trygghet och meningsfullhet.

Vårdföretagarna (svensk arbetsgivar- och bransch-organisation för vårdgivare) publicerade en artikel där Moa Engström (aktivitetsansvarig på boendet Villa Basilika) berättar om hur det är att ge personer med demens en chans att skapa sin egen konst.[8] I artikeln berättas det om hur Engström målade tillsammans med de boende, som alla hade någon typ av demenssjukdom. Skapandet väckte minnen från förr hos de boende, och artikeln nämner att både Engström, övriga personalen och de anhöriga upplevde de boende som mycket tryggare efteråt. Engström berättar även att hon har som mål att låta de boende skapa konst för Liljevalchs vårsalong, för att öka kunskapen kring konstens positiva effekter. Jag har inte hittat någon information om huruvida projektet togs vidare, men Engström påpekar att det oavsett så finns det potential att använda mer konst och skapande inom vården för att lindra demenssjukdomar.

3.2 Bildpedagogik och demenssjukdomar

Konst har goda effekter på människors hälsa, inte minst för personer med demens. Men *hur* lärs konst ut till personer med demens? Att lära sig konst är en *estetisk lärprocess*, ett begrepp som Eva Hallgren (fil.dr, dramapedagog och mellanstadielärare) och Ewa Jacquet (lärare och dramapedagog) tar upp i boken *Stärk pedagogiken med estetiken: drama, bild och muntligt berättande i tematisk undervisning*.[9] Författarna använder estetiska lärprocesser med utgångspunkt i skolmiljöer, och begreppet innebär att lära sig genom någon typ av skapande och uttrycksform.[10] Hallgren och Jacquet använder tre sorters estetiska uttryck som grunder, varav *bild* är en av dem. Fortfarande med utgångspunkt i skolmiljöer så menar författarna att elever är vana vid att konsumera visuella verk, vilket ger en mer direkt ingång till en lärprocess än skrivna verk.[11] Bild innebär också lärande kring att både kommunicera med och

[6] Ibid, sid. 44-45.
[7] Alzheimer Society Saskatchewan, *Meaningful Activity*, https://alzheimer.ca/sites/default/files/documents/Meaningful-activity-booklet_Alzheimer-Society-of-Saskatchewan.pdf, 14 april 2026.
[8] Vårdföretagarna, *Kreativt skapande lugnar och väcker minnen för demenssjuka på Villa Basilika*, https://www.vardforetagarna.se/2019/12/kreativt-skapande-lugnar-och-vacker-minnen-for-demenssjuka-pa-villa-basilika/, 16 april 2026.
[9] Eva Hallgren & Ewa Jacquet, *Stärk pedagogiken med estetiken: drama, bild och muntligt berättande i tematisk undervisning*, Studentlitteratur AB: Lund, 2023.
[10] Ibid, sid. 15-19.
[11] Ibid, sid. 35.

att tolka visuella resurser, enligt författarna, vilket gör att estetiska lärprocesser är utvecklande för elevernas tänkande.

Även om Hallgren och Jacquet utgår från skolmiljöer så är estetiska lärprocesser via bild något som också kan användas för personer med demens.[12] Det kräver dock ett annat förhållningssätt än med arbete i skolmiljöer. Sinthia Cousineau (utbildad pedagog och terapeut inom bildämnet) berättar på sin webbplats om erfarenheterna kring att undervisa personer med demens.[13] Hon menar att som bildpedagog för målgruppen behövs en stor del planering och tålamod, då deltagarnas sjukdomar medför svårigheter med minne och rörlighet. Därför krävs det som bildpedagog en förståelse för hur demenssjukdomar påverkar hjärnan. Utifrån Cousineaus råd försöker jag skapa mig en god grund kring sjukdomarna innan jag påbörjar den praktiska delen av min studie, för att främja den estetiska lärprocessen.

För att planera och utföra aktiviteter för personer med demens krävs det även att du som pedagog är anpassningsbar. I sitt informationshäfte kring aktiviteter för personer med demens ger Alzheimer Society Saskatchewan tips på hur aktiviteterna kan planeras.[14] Bland annat handlar det om att hålla det enkelt, och inte ge för mycket instruktioner som kan bli överväldigande för deltagaren. Sedan bör man anpassa aktiviteten efter personens dagliga rutin, och efter den tidpunkt som hen är mest aktiv. Förberedelser och planering av aktiviteten är viktigt för att deltagaren bäst ska hålla fokus, och om personen inte gillar att delta så kan man försöka igen vid en annan tidpunkt. Att ha kreativt lagda aktiviteter är också en fördel, då personen får utrymme att uttrycka sig. Viktigt är att främja den energi som personen redan har, och inte stoppa processen. Här kan instruktionerna sammanfattas till att vara *tydlig*, *förberedd, anpassningsbar* och *uppmuntrande*. Instruktionerna kommer att bli ledord för mig som bildpedagog i en studie som kretsar kring demenssjukdomar.

3.3 Träd som motiv

För att främja den estetiska lärprocessen i min studie så vill jag hitta ett tema som mina deltagare kan arbeta med. *Träd* är ett motiv som besitter mycket symbolik, vilket gör det lämpligt som tema. Sam Harrelson (forskare inom ekoteologi) beskriver på sin webbplats hur träd har stor betydelse inom flera religioner.[15] Genom historien har träd symboliserat liv, visdom och sammankoppling, menar Harrelson, och tar upp flera exempel på träds betydelse i religioner. Bland annat nämner han *baobab*- och *iroko-träden* från afrikanska religioner, som agerar husrum för förfäder och därmed blir en samlingsplats för samhället. *Yggdrasil* från nordisk mytologi tas också upp, och är ett jättelikt träd som hela universum vilar på, och vars rötter dricker vatten från visdomens källa. I kinesisk mytologi finns *odödlighetens persikoträd* (engelska: *the peach tree of immortality*), som vart 3000:e år bär frukt som ger evigt liv.

---

[12] Ibid.

[13] Sinthia Cousineau, *Art & Seniors*, https://www.sinthiacousineau.com/art-education--older-adults.html, 13 april 2026.

[14] Alzheimer Society Saskatchewan, *Meaningful Activity.*

[15] Sam Harrelson, *Trees as Symbols of Life and Spirit Across Religions*, https://samharrelson.com/2025/08/22/trees-as-symbols-of-life-and-spirit-across-religions/, 21 april 2026.

Träd är likväl ett motiv som ofta förekommer i konstnärliga sammanhang, vilket också gör temat passande i mina workshops. *Tate* (ett museinätverk i Storbritannien) tar på sin webbplats upp exempel på målningar och skulpturer av träd, och hur konstnärerna har varierat trädens grenar, tjocklek och texturer för olika effekter. De avbildade träden i exemplen varierar stort. I installationen *from 'Our Love is Like the Flowers, the Rain, the Sea and the Hours'* har Martin Boyce skapat geometriskt formade träd som lyser likt gatlyktor.[16] Peter Doig har i sin djuptryckta bild *Concrete Cabin* fokuserat på trädens silhuetter för att vagt framställa en stuga i skogen.[17] Keith Coventrys skulptur *Burgess Park SE5, Planted 1983, Destroyed 1988* består av en avgjutning av en avkapad trädstam som efterliknar ett minnesmonument.[18] De avbildade träden är väldigt olika, men samtliga går ändå att känna igen som just träd.

3.4 Vad är demens?

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn på sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar våra kognitiva förmågor, enligt Hjärnfonden (svensk stiftelse inriktad på forskning kring hjärnsjukdomar).[19] Kognitiva förmågor innebär de förmågor som är kopplade till vårt tänkande och intellekt. Förändringarna kan yttra sig på flera olika sätt, men ökar alltid med tiden. När dessa förändringar skapar problem i arbete och/eller det sociala livet så uppfyller de kriterierna för en demensdiagnos. I nuläget finns inget botemedel mot demenssjukdomar, men i flera fall kan symtomen dämpas med hjälp av läkemedel.

Den allra vanligaste demenssjukdomen är *Alzheimers sjukdom* (ofta bara kallad "Alzheimer"), som enligt Hjärnfonden utgör ca. 60–70% av alla fall.[20] Sjukdomen innebär att hjärnans nervceller bryts ner och dör, och yttrar sig i form av minnes- och kommunikationssvårigheter, försämrat lokalsinne och tidsuppfattning, samt svårigheter att utföra viktiga kroppsrörelser. Den näst vanligaste demenssjukdomen är *vaskulär demens*, och utgör ca. 25% av fallen.[21] Den beror på förändringar i blodkärl som gör att näring och syre inte transporteras lika bra till hjärnan, till exempel i samband med stroke, diabetes, eller hjärtsjukdomar. Symtomen beror på vilken del av hjärnan som skadas, och kan yttra sig i form av personlighetsförändringar, försämrad analysförmåga, samt problem med rörlighet och talförmåga. *FTD* (Frontotemporal demenssjukdom) beror på hjärnceller som dör och skapar strukturförändringar i hjärnans främre delar, enligt SweFTDI (svenskt konsortium

[16] Martin Boyce, *from 'Our Love is Like the Flowers, the Rain, the Sea and the Hours' [installation]*, Tate, 2002. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/boyce-from-our-love-is-like-the-flowers-the-rain-the-sea-and-the-hours-t12132, 21 april 2026.
[17] Peter Doig, *Concrete Cabin [djuptryck]*, Tate, 1996. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-concrete-cabin-p11479, 21 april 2026.
[18] Keith Coventry, *Burgess Park SE5, Planted 1983, Destroyed 1988 [bronsskulptur]*, Tate, 1994. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-concrete-cabin-p11479, 21 april 2026.
[19] Hjärnfonden, *Vad är demens och demenssjukdom?*, https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnos/demens/vad-ar-demens/, 2 februari 2026.
[20] Hjärnfonden, *Vad är Alzheimers sjukdom?*, https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnos/alzheimers-sjukdom/vad-ar-alzheimers-sjukdom/, 2 februari 2026.
[21] Hjärnfonden, *Vad är demens och demenssjukdom?*

inriktad på forskning kring sjukdomen).[22] Sjukdomen drabbar inte minnet i första hand, utan symptomen yttrar sig mer i beteendeförändringar och svårigheter att uttrycka sig i tal. FTD är relativt outforskad och därför svår att hitta statistik för, men SweFTDI uppskattar att sjukdomen står för 2–10% av alla demensfall i Sverige.

Enligt Svenskt Demenscentrum (svensk stiftelse inriktad på information kring demenssjukdomar) kan en diagnostiserad demenssjukdom delas upp i fyra stadier: *begynnande*, där de allra första symtomen kommer smygande medan personen ännu är medveten om dessa; *mild*, där problem med minne och orientering börjar bli mer påtagliga; *medelsvår*, där symtomen är så stora att personens medvetenhet kring sjukdomen avtar och vårdinsatser krävs; och *svår*, där större delen av hjärnan är skadad, och sjukdomen påverkar personen fysiskt till den grad att gångförmågan oftast försvinner.[23] Många personer i sjukdomens sista stadie avlider i sekundära sjukdomar, såsom lunginflammation eller hjärtsvikt.

År 2021 hade 57 miljoner människor i världen någon typ av demenssjukdom, enligt WHO:s beräkningar.[24] Varje år drabbas närmare 10 miljoner människor, och demens är den sjunde mest förekommande dödsorsaken. Även om ålder är den största riskfaktorn så menar WHO att ca. 9% av personer med demenssjukdomar är under 65 år, och har så kallad "tidig demens". Enligt Karolinska Institutets (svenskt universitet inriktad på medicin) forskningsrapport ansågs antalet personer med demenssjukdomar i Sverige vara 130 00-150 00 år 2023, och uppskattas öka till 230 000-270 000 personer år 2050.[25]

3.5 Språkbruk och stigmatisering kring demens

Hur benämner vi personer med demenssjukdomar på ett respektfullt sätt? I "Dementism och ålderism", ett kapitel i antologin *Perspektiv på ålderism,* tar Lars-Christer Hydén (professor i socialpsykologi) och Atiqur Rahman (doktorand med inriktning mot demens och studier av åldrande) upp språkbruket kring personer som lever med demenssjukdomar, och anser att "dement" är ett nedsättande begrepp som anger personens begränsningar.[26] Att istället sätta personen i centrum är ett viktigt steg mot att inkludera personer med demenssjukdomar i samhället, menar författarna. Genom kapitlet använder författarna en rad olika beteckningar, oftast "personen som lever med demens", men även "personen med demenssjukdom" eller "personen med demens". "Demens" och "demenssjukdom" används synonymt med varandra i kapitlet. Därför kommer även jag använda mig av Hydéns och Rahmans beteckningar för att sätta personen i fokus, samtidigt som jag undviker att andvända ordet "dement" i min studie.

---

[22] Swedish FTD Initiative, *Vad är FTD?*, https://frontallobsdemens.se/att-leva-med-frontlobsdemens/vad-ar-ftd/, 26 februari 2026.
[23] Svenskt Demenscentrum, *Sjukdomens faser, https://demenscentrum.se/fakta-om-demens/demenssjukdomar/alzheimers-sjukdom/sjukdomens-faser,* 2 april 2026.
[24] World Health Organization, *Dementia*.
[25] Karolinska Institutet, *Antalet demenssjuka och kostnader för demenssjukdomar i Sverige 2023*, https://news.ki.se/media/150869/download, 16 februari 2026.
[26] Hydén & Rahman, "Dementism och ålderism", sid. 126.

Hydén och Rahman tar även upp att det finns ett *stigma* kring demenssjukdomar Sverige.[27] Ordet "stigma" innebär, enligt författarna, antingen att en person uppfattar sig ha egenskaper som uppfattas negativt av andra, eller att andra uppfattar att en person har negativa egenskaper.[28] Även Dementia UK (en brittisk välgörenhetsorganisation inriktad på demens) menar att det finns ett stigma mot demenssjukdomar, och beskriver ordet "stigma" som negativa uppfattningar kring en person, baserat på stereotyper.[29] Det bästa sättet att motverka stigmat kring demens, enligt Hydén och Rahman, är utbildning kring åldrandets konsekvenser och demenssjukdomar, samt offentliga kampanjer som ger personerna ett ansikte utåt.[30] Dementia UK menar också att det är viktigt att sprida information om sjukdomarna, och även inkludera personerna i sociala sammanhang samt fokusera på deras styrkor istället för svagheter.[31] Här ser jag en möjlighet att använda min studie som en kampanj för att bidra med kunskap kring demens och på så sätt motverka stigmat.

4. Teoretiskt perspektiv

Min studie betraktas genom *relationell pedagogisk teori* och *sociokulturell teori*. I den förstnämnda teorin är *mellanmänskligt* och *etik* genomgående begrepp, medan i den sistnämnda är *språk* det centrala temat. Nedan går jag igenom teorierna och hur jag kommer att betrakta min studie genom dem.

4.1 Relationell pedagogisk teori

Relationell pedagogisk teori tar avstamp i forskningsfältet "relationell pedagogik", där fokus ligger på relationer snarare än enskilda individer och strukturer. I boken *Om relationell pedagogik* menar Jonas Aspelin (professor i pedagogik) och Sven Persson (professor i pedagogik) att fältet inte är ett statiskt teoretiskt system, utan är under ständig utveckling.[32] Dock menar författarna att fältet är applicerbart på forskning och arbete inom skola och undervisning, där forskare, lärare, lärarstudenter och övriga som är engagerade inom utbildning kan bidra med ny kunskap. Då jag som lärarstudent tar mig an rollen som bildpedagog och bygger relationer med mina deltagare med demenssjukdomar, så ser jag det relationella pedagogiska fältet som teoretiskt applicerbart på min egen studie.

Ett centralt begrepp i relationell pedagogisk teori är *mellanmänskligt*, som används i olika aspekter. I kapitlet "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus", publicerat i antologin *Vetenskapliga teorier för lärare,* tar Åsa Hirsh (docent i pedagogik) upp relationell pedagogisk teori, som hon anser kan användas som ett "klassrumsnära" verktyg för att hjälpa

[27] Ibid.
[28] Ibid. sid. 118.
[29] Dementia UK, *Dealing with the stigma of dementia*, https://www.dementiauk.org/information-and-support/living-with-dementia/dealing-with-stigma/, 8 april 2026.
[30] Hydén & Rahman, "Dementism och ålderism", sid. 118.
[31] Dementia UK, *Dealing with the stigma of dementia*.
[32] Jonas Aspelin & Sven Persson, *Om relationell pedagogik*, Gleerups Utbildning AB: Malmö, 2011, sid. 21-22.

lärare att förstå sitt undervisande yrke.[33] Där beskriver hon den mellanmänskliga sfären som den typ av miljö där relationer spelar stor roll - bland annat skolmiljöer. Aspelin och Persson utgår från Joachim Israels (professor i sociologi) definition, som beskriver mellanmänskliga relationer som skeenden där två människor förhåller sig till varandra som subjekt.[34] Så den mellanmänskliga *sfären* syftar alltså på miljön, medan *relationerna* syftar på händelserna. Jag kommer att utföra en studie i vårdmiljö där människor med varierande förutsättningar står i fokus, vilket gör vårdmiljön till en mellanmänsklig sfär. Genom att blicka genom denna mellanmänskliga sfär så kan jag analysera hur de mellanmänskliga relationerna mellan mig och deltagarna utförs.

Hirsh menar också att inom relationell pedagogisk teori är den *etiska* dimensionen central, liksom behovet att agera utifrån människors olikheter.[35] I boken *Skillnadens pedagogik* så tar Carl Anders Säfström (docent i pedagogik) också upp vikten av etik och moraliskt perspektiv i relationell pedagogik, och menar att lärarens kunskap och information om sina elever blir en slags "icke-mänsklig relation" där läraren bär ett extra stort ansvar.[36] Då jag i min studie kommer att arbeta med personer med demens så kommer varje person vara i ett eget stadium av sin sjukdom, vilket medför väldigt varierande förutsättningar. Det gör också att jag själv måste gå in i denna "icke-mänskliga relation" och axla ett ansvar, eftersom jag får tillgång till information om mina deltagare. Genom att betrakta studien genom ett etiskt perspektiv så kan jag analysera hur en workshop för målgruppen kan arrangeras utifrån deltagarnas olikheter, och göra det med största respekt för deltagarna.

4.2 Sociokulturell teori

I en sociokulturell teori är *språk* i sociala processer ett genomgående tema. Det gör den nära besläktad med relationell pedagogisk teori, då både språk och relationer bygger på interaktioner mellan människor. Roger Säljö (professor i pedagogik) menar i rapporten "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande", publicerad i tidskriften *Utbildning & Demokrati*, att teorin bygger på att kunskap inte är något som finns inom individer, utan utvecklas *mellan* individer.[37] Även i denna teori är alltså relationer av stor vikt, vilket går in på min studies syfte. En del av mitt syfte är att ta reda på hur en konstnärlig workshop för personer med demens kan arrangeras, vilket gör att jag går in i rollen som bildpedagog. Och som bildpedagog i min studie interagerar jag med deltagare som alla har varierande förutsättningar, vilket gör språket av stor vikt, och därmed ser jag det sociokulturella fältet som teoretiskt applicerbart på min studie.

---

[33] Åsa Hirsh, "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus", i *Vetenskapliga teorier för lärare*, redigerad av Margareta Serder & Anna Jobér, Stockholm: Natur & Kultur, 2021.
[34] Aspelin & Persson, *Om relationell pedagogik*, sid. 42; Joachim Israel, *Martin Buber - Diagnosfilosof och sionist*, Stockholm: Natur & Kultur, 1992, sid. 103.
[35] Ibid.
[36] Carl Anders Säfström, *Skillnadens pedagogik*, Lund: Studentlitteratur, 2005, sid. 77.
[37] Roger Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande", i Utbildning & Demokrati, 20(3), 2011, sid. 67-85.

I kapitlet “Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap”, publicerat i antologin *Vetenskapliga teorier för lärare,* tar Maria Rubin (lektor i pedagogik) upp sociokulturella teorier och tankegångar.[38] Dessa teorier och tankegångar baseras på människan som en social varelse, där språket blir det främsta verktyget för att föra vidare information. Rubin tar upp ett klassrumsbaserat exempel kring språkbruk.[39] Där håller läraren en lektion i anatomi (specifikt, hjärtat och dess olika delar), och använder vetenskapliga termer i sina beskrivningar, samt presenterar en bild på hjärtat. Läraren anpassar sig till elevernas kunskaper, och använder jämförelser av olika slag för att beskriva hjärtats delar i mer vetenskapliga termer (till exempel genom att likna aortan med en tusenfoting). Likväl menar Säljö att språket i lärande är av *kontextuell* natur, och måste anpassas beroende på sammanhanget.[40] I min egen studie kommer jag analysera empirin med språket som utgångspunkt, och ta vara på hur språket anpassats i olika sammanhang. Olika sammanhang kan till exempel vara att analysera hur jag förmedlat information åt mina deltagare, och tvärtom, hur mina deltagare har förmedlat information åt mig. Och då mina deltagare kommer teckna träd så kommer även bildspråket vara en utgångspunkt i min analys.

5. Tidigare forskning

För att kunna få en bild av forskningsläget kring konstnärligt arbete inom vården så har jag letat tidigare forskning via EBSCO, Konstfacks bibliotek, samt Google. Jag har sökt på både svenska och engelska, med två sökord åt gången, för att få ett bredare urval. I mina sökningar har jag i första hand haft bildpedagogik (engelska: “art education”) då det är det är den röda tråden i mitt syfte. Som andra sökord har jag främst antingen haft “demens” (engelska: “dementia”) eller “vård” (engelska:” healthcare”), då även de hänger ihop med mitt syfte. Mina sökningar har därför främst varit “bildpedagogik och demens" (engelska: “art education and dementia”) och så vidare. I mina workshops så är träd det genomgående temat, och därför har jag även haft “träd” (engelska: “trees”) som sökord, i kombination med både “bildpedagogik/art education”, “demens/dementia” och “vård/healthcare”.

Genom sökningarna har jag hittat flera forskningsartiklar och rapporter som rör konstnärligt arbete inom vården, där många är specifikt inriktade på bildpedagogik och demens. Jag har även valt att ta med en forskningsstudie som inte specifikt behandlar konstnärligt arbete eller demens, men ändå går att applicera på min egen studie. Studien i fråga är Geoffrey H. Donovans m.fl. studie kring plantering av träd, trots att den varken behandlar konstnärligt arbete eller demens.[41] Studien visar dock på trädplanteringens positiva effekter för människors hälsa, och då träd är det grundläggande temat i mina workshops så ser jag Donovans m.fl. studie som relevant. Jag har däremot valt bort forskning som enbart rör

[38] Maria Rubin, “Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap”, i *Vetenskapliga teorier för lärare*, redigerad av Margareta Serder & Anna Jobér, Stockholm: Natur & Kultur, 2021.
[39] Ibid, sid. 256.
[40] Säljö, “Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande” sid. 77.
[41] Geoffrey H. Donovan, Jeffrey P. Prestemon, Demetrios Gatziolis, Yvonne L. Michael, Abigail R. Kaminski & Payam Dadvand, “The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis”, *Environment International*, 170, 2022, sid. 1-7, DOI:10.1016/j.envint.2022.107609.

bildpedagogik i skolmiljö, då jag upplevde det svårt att applicera på en målgrupp med nedsatta kognitiva förmågor. För att få en översikt så har jag delat upp den tidigare forskningen i underrubriker, som jag går igenom nedan.

5.1 Konst, bildpedagogik och demens

Konst har positiva effekter på kognitiva funktioner, som Daisy Fancourt och Saoirse Finn tar upp i rapporten *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*.[42] Det finns även forskning som visar att de positiva effekterna specifikt kan gälla talförmåga och långtidsminne. I artikeln "The impact of viewing and making art on verbal fluency and memory in people with dementia in an art gallery setting", publicerad i tidskriften *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts,* presenterar Rhea Young (doktorand i klinisk psykologi) med kollegor en studie för att ta reda på vilken inverkan skapande och betraktande av konst har på talspråket och minnet hos personer med demens.[43] Studien utfördes under flera sessioner med patienter med demens, och varje session bestod av tre delar som fokuserade på varsin aspekt; diskuterande, betraktande, och skapande. Resultatet visar att deltagarnas talsvårigheter minskade under veckorna (särskilt under de delar som fokuserade på skapande), samt att deltagarnas långtidsminne förbättrades. I resultatet framgår dessutom att deltagarnas talsvårigheter minskade som mest när de fick skapa konst jämfört med att betrakta konst. Young m.fl. utförde visserligen en långtidsstudie, men konstens positiva effekter på kognitiva funktioner är påtagliga här.

Relationer spelar en viktig roll i studier kring konst och demenssjukdomar. I artikeln "'It makes me feel like myself': Person-centered versus traditional visual arts activities for people with dementia", publicerad i tidskriften *Dementia,* presenterar Philip E. Sauer (doktorand inom socialgerontologi) med kollegor en studie kring konstprojektet OMA (Opening Minds through Art), där de mätte välbefinnandet respektive missnöjet hos deltagarna.[44] OMA:s upplägg innebär att personer med demens får arbeta konstnärligt, och slås ihop med varsin yngre volontär som assisterar och uppmuntrar. Resultatet av Sauers m.fl studie visar att välbefinnandet hos personerna med demens var väldigt starkt, och forskarna upplevde det sociala utbytet som likvärdigt mellan både deltagarna och volontärerna. Deltagarna upplevdes vara motiverade av volontärernas insatser, och volontärerna beskrev upplevelserna som givande.

En bildpedagog för personer med demenssjukdomar bör vara påläst, besitta empati, och ge deltagarna valmöjligheter. I tidskriftsartikeln "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative

[42] Fancourt & Finn, *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*, sid. 24-25.

[43] Rhea Young, Victoria Tischler, Sarah Hulbert & Paul M. Camic, "The impact of viewing and making art on verbal fluency and memory in people with dementia in an art gallery setting", *Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts*, 9(4), 2015, sid. 368–375, DOI:10.1037/aca0000030.

[44] Philip E. Sauer; Joan Fopma-Loy; Jennifer M. Kinney & Elizabeth Lokon, ""It makes me feel like myself": Person-centered versus traditional visual arts activities for people with dementia", *Dementia,* 0(0), 2014, sid. 1-18, DOI:10.1177/1471301214543958.

exploration", publicerad i *Dementia,* presenterar Emily Shoesmith (forskare inom demenssjukdomar) med kollegor en studie för att ta reda på hur konstnärliga åtgärder inom vården utförs bäst.[45] I studien intervjuades personer med demens, samt vårdgivare och professionella konstutövare som arbetat med personer med demens. I intervjuerna ställdes frågor kring personernas erfarenheter av konstnärliga insatser inom vården. Resultatet visar att som bildpedagog för målgruppen bör du vara påläst kring både konst och demenssjukdomar, vara empatisk och tålmodig, ha ett icke-bedömande förhållningssätt, ge deltagarna valmöjligheter i material, samt lägga fokus på deltagarnas skapande istället för resultat.[46] Studiens resultat visar även att konstnärligt grupparbete för personer med demens ger en känsla av trygghet, och en möjlighet att bygga gemenskaper.

Konst förmedlas bäst genom att låta deltagarna vara delaktiga. Under 2018 genomfördes ett följeforskningsprojekt kring guidade konstvandringar inom geriatrisk vård vid Nacka sjukhus, med syftet att öka patienternas (som alla hade nedsatta fysiska och/eller kognitiva förmågor) välbefinnande. Max Liljefors (professor i konsthistoria och visuella studier) och Åsa Alftberg (etnolog och universitetslektor) gjorde en forskningsrapport på detta projekt, som publicerades av Kulturförvaltningen.[47] Forskarna tog reda på hur konstvandringarna i projektet upplevdes av patienterna, genom att observera vandringarna och samtalen som uppstod. I rapportens slutsats bedömdes projektet vara lyckat med ett aktivt engagemang från deltagarna, vilket hade mycket att göra med det pedagogiska upplägget menar Liljefors och Alftberg. Under konstvandringarna på Nacka sjukhus användes en *dialogbaserad konstpedagogik*, där pedagogen var öppen för patienternas egna tolkningar och åsikter istället för att enbart prata själv. Därmed fick patienterna större chans att ta till sig av informationen, genom att själva vara delaktiga i samtalen kring konstverken.

Personer med demens blir delaktiga även genom att själva skapa konst. I artikeln "Co-creating an Art Exhibition on Living Well With Dementia", publicerad i tidskriften *AMA Journal of Ethics*, presenterar Gloria Puurveen (filosofie doktor vars forskning fokuserar på demenssjukdomar och vård i livets slutskede) med kollegor en utforskande studie kring att arrangera ett konstprojekt för att öka kunskapen kring demens.[48] Forskarna började med att intervjua personer med demens och deras vårdgivare, som därefter deltog i workshops där de skapade konst och skrev tillhörande texter. Konstverken ställdes ut i en onlineutställning, som forskarna arrangerade utifrån feedback från deltagarna. Puurveen m.fl. går inte in på detalj kring deltagarnas egna upplevelser av studien, men resultatet visar att deltagarnas delaktighet i utställningens utformning gjorde att deras röster effektivt fick höras. Varje konstverk fick sitt personliga uttryck, och som forskarna påpekar så var inget konstverk det andra likt.

---

[45] Emily Shoesmith; Claire Surr & Divine Charura, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration", *Dementia*, 20(4), 2020, sid. 1-27, DOI:10.1177/1471301220938481.

[46] Ibid. sid. 7.

[47] Max Liljefors & Åsa Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, Kulturförvaltningen: Region Stockholm, 2019, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410160/FULLTEXT01.pdf.

[48] Puurveen; Cox; Damiano; Neale Furneaux & Pineda Sierra, "Co-creating an Art Exhibition on Living Well With Dementia", sid. 622-633.

Forskarna berättar även att antalet besökare var större än väntat, och via feedback så upplevde många av besökarna att de fått mer inblick i demens och personerna som lever med sjukdomarna.

Sammanfattningsvis från forskningen kring konst, bildpedagogik och demenssjukdomar så har konst goda effekter på människors hälsa, inte minst för personer med demenssjukdomar. Men för att de goda effekterna ska fungera så måste konsten förmedlas på ett begripligt sätt. Detta görs bäst genom att bildpedagogen öppnar upp för deltagarnas diskussioner och egna berättelser för att de ska känna sig delaktiga, vilket jag kommer att fokusera på i mina workshops. En bildpedagog som arbetar med personer med demens bör vara stöttande, inspirerande och främja det personliga uttrycket, vilket jag kommer lägga stor vikt vid. Som bildpedagog bör man också vara tålmodig och anpassningsbar, och jag kommer därför ha stort fokus på min flexibilitet. En timme per workshop är en passande tid för att behålla deltagarnas fokus. Något som däremot inte tas upp i forskningen är vilket konstnärligt material som fungerar bäst för personer med demens. I den tidigare forskningen används en stor mängd konstnärligt material, men väldigt lite fokus på vad som fungerar bäst för målgruppen. Det närmaste jag har att utgå ifrån är Shoesmiths m.fl. beskrivning att ge deltagarna en mängd material att välja mellan, och att undvika material som uppfattas som "barnsligt" (t.ex färgkritor).[49] Här ser jag ett kunskapsglapp värt att utforska i min egen studie, genom att närmare ta reda på vilken typ av konstnärligt material som passar bäst i en workshop för personer med demens.

5.2 Träd och demens

Jag vill låta mina studiedeltagare teckna träd, och det finns forskning som bevisar varför träd är ett passande tema. I Max Liljefors och Åsa Alftbergs rapport kring konstvandringarna på Nacka sjukhus så är träd ett motiv som kan öppna upp för reflektioner och tolkningar.[50] I rapporten följde forskarna med på en konstvandring på konstutställningen *Träd* av Maria Boij. Konstverken i utställningen bestod dels av en keramikskulptur föreställande ett träd, och dels av porslinstallrikar (som hade monterats på väggen i molnformationer) dekorerade med lövverk. Liljefors och Alftberg beskriver flera reflektioner som uppkom hos patienterna under konstvandringen; bland annat liknades trädskulpturen vid LEGO, en cancersvulst, och svampmolnet från en atombomb. Tallrikarna öppnade också upp för flera tolkningar, där flera av patienternas egna erfarenheter uppkom. Patienternas starka engagemang och många reflektioner under Maria Boijs utställning *Träd* tyder därför på att just träd är ett tema som ger deltagarna möjlighet att själva tänka och reflektera.

Träd är ett motiv som personer med demens kan teckna och avbilda. I tidskriftsartikeln "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment" som publicerades i *Behavioural Neurology,* använde Michelangelo Stanzani Maserati

[49] Shoesmith; Surr & Charura, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration", sid. 13-14.
[50] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, sid. 14-16.

(medicine doktor) med kollegor The Tree-Drawing Test (TDT) i en studie.[51] Testet, som även kallas Koch's Baum Test, beskrivs av forskarna som ett sätt att fastställa en människas personlighet genom att hen tecknar ett träd, vars grenar, stam och lövverk sedan mäts. I detta fall ville Stanzani Maserati ta reda på huruvida testet kunde användas för att diagnosticera demens, och utfördes med personer med olika typer av demenssjukdomar. Deltagarnas uppdrag var att teckna ett träd på ett A4-papper, och efteråt mättes trädets olika delar. Studien visar att just träd är ett lämpligt motiv för mina deltagare med demens, då träd har enkla former som går att variera. Dessutom hade Stanzani Maseratis m.fl. deltagare många olika typer av demenssjukdomar, vilket också gör motivet lämpligt för deltagare med varierande symptom och sjukdomsförlopp.

Träd besitter symbolik och är igenkännbara, vilket gör det till ett passande motiv för konst i vårdnära syften. Christine Isaksson (forskare inom socialt arbete) med kollegor gjorde en studie, publicerad i artikeln "Changes in self-image as seen in tree paintings" i tidskriften *The Arts in Psychotherapy,* för att ta reda på hur patienter använde självbilder i målningar av träd.[52] Deltagarna, som alla var sjukskrivna av olika skäl, fick måla träd under två tillfällen. Målningarna analyserades efteråt genom att jämföra trädets olika delar, med inspiration av The Tree-Drawing Test. Resultatet var i detta fall svårtolkat på grund av spridningen i deltagarnas målningar, något som Isaksson m.fl. påpekar. Det som dock är intressant är att forskarna i studien motiverar valet av tema genom att träd har mycket symbolisk betydelse; det har representerat livet och döden genom historien, och dess utformning kan liknas vid en människas (båda har en vertikal hållning, står på marken, och besitter ett system som pumpar vätska genom kroppen). Resultatet tyder också på att träd var ett motiv som alla deltagarna i studien kunde avbilda, tack vare trädets symbolik och igenkännbara drag.

Det finns även underlag för att plantering av träd har goda effekter på människors hälsa. I artikeln "The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis", publicerad i tidskriften *Environment International*, presenterar Geoffrey H. Donovan (filosofie doktor i skogsekonomi) med kollegor en studie kring Friends of Trees, en ideell förening som planterar träd inne i Portland.[53] Föreningen planterar träd både via sammankomster, och genom att stadsborna själva beställer träd. Forskarna mätte den hälsorelaterade dödligheten hos personerna som planterade träden, från 2006 till 2019. Resultaten i Donovans m.fl. studie visar på att dödligheten hos personerna minskade, och framförallt skedde en minskning av antalet dödsfall som berodde på hjärt- och kärlsjukdomar. Minskningen av dödsfall var även extra påtaglig hos personer över 65 år, enligt resultatet av studien.

---

[51] Michelangelo Stanzani Maserati, Corrado Matacena, Luisa Sambati, Frederico Oppi, Roberto Poda, Maddalena De Matteis & Roberto Gallassi, "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment", *Behavioural Neurology*, 2015, sid. 1-6, DOI:10.1155/2015/534681; ResearchGate, *Profile: Michelangelo Stanzani Maserati*, https://www.researchgate.net/profile/Michelangelo-Stanzani-Maserati, 10 april 2026.

[52] Cristine Isaksson, Ann-Katrin Norlén, Birgitta Englund &
Rafael Lindqvist, "Changes in self-image as seen in tree paintings", *The Arts in Psychotherapy*, 36(5), 2009, sid. 304–312, DOI:10.1016/j.aip.2009.07.004.

[53] Donovan, Prestemon, Gatziolis, Michael, Kaminski & Dadvand, "The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis", sid. 1-7; ResearchGate, *Profile: Geoffrey H. Donovan*, https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey-Donovan, 10 april 2026.

Sammanfattningsvis från forskningen om träd och demens så är träd ett motiv som är enkelt att teckna, samtidigt som det är igenkännbart, går att variera, och besitter symbolik. Det gör träd till ett passande motiv för deltagare med nedsatta kognitiva förmågor att teckna. Motivet kan även väcka reflektioner och minnen från förr, vilket gör det intressant att använda för personer med minnessvårigheter. Plantering av träd har också en positiv effekt på människors hälsa, vilket jag kan använda mig av i en konstnärlig bemärkelse; mina deltagare får plantera träd, fast med hjälp av konstens verktyg. Men även om forskningen visar att personer med demens kan avbilda och reflektera kring träd så hittar jag inget om vad personernas egna åsikter kring att avbilda träd. Liljefors och Alftbergs rapport är inriktad på betraktande av konst istället för skapande, och Stanzani Maseratis m.fl. och Isakssons m.fl. studier har större fokus på resultatet än processen.[54] Här ser jag ett kunskapsglapp värt att utforska, där jag i min studie tar reda på vad mina egna deltagare själva tycker om att teckna just träd, genom att fokusera på processen av varje workshop.

6. Metod och material

När jag planerade mina workshops utgick jag främst från forskaren Emily Shoesmiths med kollegors studie kring konstnärliga åtgärder inom vården, forskarna Max Liljefors och Åsa Alftbergs forskningsrapport kring guidade konstvandringar, bildpedagogen Sinthia Cousineaus erfarenheter och råd, samt välgörenhetsorganisationen Alzheimer Society Saskatchewans tips på hur aktiviteter kan planeras.[55] Men även med referenserna som grund så valde jag att hålla en flexibel struktur, då jag inte kände till deltagarna helt innan. Den information jag hade att utgå ifrån var gruppchefernas beskrivningar av de potentiella deltagarna, samt eventuella begränsningar som rörde deltagarna. I min studie vill jag ta reda på deltagarnas upplevelser av att teckna träd under mina workshops, vilket har gett mig flera alternativ kring metoder. Dock har jag haft vissa begränsningar att utgå ifrån. Mina deltagare med demens har någon grad av nedsatt kognitiv förmåga, vilket ofta innebär minnessvårigheter. Det gjorde att jag valde bort intervjuer som metod. Verksamhetscheferna på varje boende nämnde att flera deltagare inte ville bli inspelade, vilket gjorde att jag även valde bort inspelningar. Efter att ha läst i Tobias Olssons (lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap) bok *Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier* så har jag kunnat hitta en metod som passar min studie: att observera med hjälp av anteckningar.[56]

Eftersom jag har använt en observationsmetod som analyseras i text så kan studien främst ses som *kvalitativ*. Som Göran Ahrne (professor emeritus i sociologi) och Peter Svensson (docent

---

[54] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus*; Stanzani Maserati, Matacena, Sambati, Oppi, Poda, De Matteis & Gallassi, "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment", sid. 1-6; Isaksson, Norlén, Englund & Lindqvist, "Changes in self-image as seen in tree paintings", sid. 304–312.

[55] Shoesmith, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration"; Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*; Cousineau, *Art & Seniors*; Alzheimer Society Saskatchewan, *Meaningful Activity*.

[56] Tobias Olsson, *Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier,* Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008

i företagsekonomi) tar upp i sitt kapitel "Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen" i deras bok *Handbok i kvalitativa metoder*, så bygger kvalitativa metoder på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte är utformade för att analyseras kvantitativt med statistik.[57] Och eftersom min studie har byggt på observationer som inte analyserats med statistik, så stämmer det in på Ahrne och Svenssons beskrivning. Med det sagt så finns ett visst *kvantitativt* inslag i analysen. Då jag vill ta reda på hur många deltagare som valt varje typ av konstnärligt material, så har jag sammanställt resultatet i en tabell med siffror. Det gör att min studie använder *mixed methods*, som Ulla Eriksson-Zetterquist (professor i företagsekonomi) beskriver i kapitlet "Mixed methods" i *Handbok i kvalitativa metoder*, innebär att samla in material med både kvalitativa och kvantitativa metoder.[58] Min studie är även av *etnografiskt* slag. Som Philip Lalander (professor i socialt arbete) beskriver i kapitlet "Observationer och etnografi" i *Handbok i kvalitativa metoder*, innebär en etnografisk studie att forskaren försöker närma sig en annan persons perspektiv på tillvaron.[59] Det vill jag göra genom att ta reda på hur mina deltagare upplever att få teckna egna träd under en workshop. Lalander menar också att observationer är av stort värde i etnografiska studier, då forskaren kan se aspekter direkt på plats och skapa relationer med studiens deltagare, vilket ger mig ytterligare skäl att använda en observationsmetod.

6.1 Förberedelser

För att påbörja den praktiska delen av min studie så tog jag kontakt med ett antal äldreboenden på Gotland, och berättade om min studie. Jag fick godkännande av två äldreboenden, och mötte upp de respektive verksamhetscheferna vid varsitt tillfälle. Under båda mötena fick jag en rundtur på boendet, och sedan berättade jag om min studie och hur upplägget kunde anpassas till de potentiella deltagarna.

Innan jag påbörjade det praktiska arrangerandet av workshops såg jag till att vara förberedd med både kunskap och material inför varje workshop. Jag tog inspiration av Sinthia Cousineau, som berättar på sin webbplats om erfarenheterna kring att undervisa personer med demens.[60] Hon menar att som bildpedagog krävs en stor del planering och tålamod, samt förståelse för hur demenssjukdomar påverkar hjärnan. Därför ville jag få grundkunskap kring demenssjukdomarna, vilket jag gjort genom att läsa på hos Hjärnfonden, SweFTD och Svenskt Demenscentrum.[61] Jag utgick även från Alzheimer Society Saskatchewans informationshäfte kring hur aktiviteter för personer med demens kan arrangeras.[62] I häftet kan instruktionerna sammanfattas till att vara *tydlig*, för att hålla det enkelt och inte ge för mycket instruktioner som kan bli överväldigande för deltagaren; *förberedd,* då planering av

[57] Göran Ahrne & Peter Svensson, "Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022, sid. 9.
[58] Ulla Eriksson-Zetterquist, "Mixed methods", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022, sid. 40.
[59] Philip Lalander, "Observationer och etnografi", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022, sid. 117.
[60] Cousineau, *Art & Seniors*.
[61] Hjärnfonden, *Vad är demens och demenssjukdom?*; Swedish FTD Initiative, *Vad är FTD?*; Svenskt Demenscentrum, *Sjukdomens faser*.
[62] Alzheimer Society Saskatchewan, *Meaningful Activity*.

aktiviteten är viktigt för att deltagaren bäst ska hålla fokus; *anpassningsbar,* då man bör justera aktiviteten efter personens dagliga rutin, och om personen inte gillar att delta så kan man försöka vid annan tidpunkt; och *uppmuntrande*, som handlar om att främja den energi som personen redan har.

6.1.1 Material till workshop

I samråd med cheferna så skaffade jag material till varje workshop. Bland annat skrev jag ut sex referensbilder på olika sorters träd, då cheferna rekommenderade att jag skulle ge deltagarna visuellt stöd. Det konstnärliga materialet jag införskaffade bestod av teckningspapper i A3-storlek, färgkritor, tuschpennor, blyertspennor, radergummin, pennvässare, samt små, rektangulära papperslappar i olika färger. De färgade papperslapparna valde jag i samråd med en av cheferna, då en deltagare inte kunde delta i den ordinarie workshopen av medicinska skäl. Annars har jag främst utgått efter Sinthia Cousineaus råd kring bildpedagogik för personer med demens, då hon menar att tvådimensionella material är att föredra.[63] Cousineau berättar hur hon testade använda lera som material under en konstnärlig workshop, men där deltagarna knappt använde materialet, och de få som använde det plattade ut leran på sitt papper istället för att arbeta tredimensionellt. Därför skaffade jag endast tvådimensionella material. Emily Shoesmiths m.fl studie visar på vikten av att ge deltagarna valmöjligheter i material, vilket gjorde att jag ville ge varje deltagare möjlighet att arbeta i både färg och gråskala.[64] En av pedagogerna i Shoesmiths m.fl intervjuer avrådde dock från att använda färgkritor, då dessa kan upplevas som "barnsliga" och det är viktigt att behandla en person med demens som en vuxen människa.[65] Men här finns det utrymme för mig att ge deltagarna en chans att välja mellan kritor och övrigt material, och därmed ta reda på hur just mina deltagare använder kritorna.

6.1.2 Miljö och tidsram

Valet av miljö där varje workshop ägde rum gjordes i samråd med cheferna, och blev matsalen på det respektive boendet, då det innebar en större yta att samla flera personer vid. Liljefors och Alftberg tar även upp att varje konstvandring som de observerat har börjat med att samla deltagarna i sjukhusets patientmatsal, då lokalen erbjöd ett större utrymme samt en lugn miljö.[66] Valet av tidpunkt och längd för mina workshops gjordes också i samråd med cheferna, baserat på boendets dagsschema och personalens erfarenheter av hur länge deltagarna orkade vara aktiva. Jag och cheferna kom överens om att en timme per workshop kunde vara lämpligt, något som såväl Emily Shoesmith m.fl som Philip E. Sauer m.fl. upplevde som en passande tidsram i sina respektive studier.[67] I Max Liljefors och Åsa Alftbergs rapport menar forskarna att det är viktigt att vara anpassningsbar kring personer

---

[63] Cousineau, *Art & Seniors*.

[64] Shoesmith, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration".

[65] Ibid, sid. 13-14.

[66] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, sid. 12-13.

[67] Ibid; E. Sauer, Fopma-Loy; M Kinney & Lokon, ""It makes me feel like myself".

med nedsatta fysiska eller kognitiva förmågor, speciellt när det kommer till tidsram.[68] Det gjorde att jag siktade på en timme, men var öppen för att förkorta eller förlänga varje workshop beroende på deltagarnas aktivitet. Totalt pågick den första workshopen (som jag har namngett "Workshop A") mellan kl. 13.00–14.30, och den andra (som jag har namngett "Workshop B") mellan kl. 13.45–14.45.

När det kom till att introducera workshopen och gruppera deltagarna så fick jag också vara anpassningsbar, då jag trots allt inte kände till dem på förhand. Sinthia Cousineau tar upp ett konkret exempel kring hur hon höll en lektion i färglära och att teckna stilleben.[69] Där började hon med en kort introduktion kring ämnet, och sedan fick deltagarna teckna sina stilleben. Vidare så placerade Cousineau sina deltagare i mindre grupper istället för att alla satt vid samma bord, något som hon upplevde underlättade interaktionerna mellan deltagarna och ökade deras motivation. Jag hade detta i åtanke, men valde ändå att börja med att samla alla vid samma bord under båda mina workshops. Dels för att jag inte visste hur många deltagare som skulle vara på plats, och dels för att lättare kunna tala till alla deltagare i början av sessionen. När alla deltagarna var samlade så introducerade jag varje workshop kortfattat, utifrån Cousineaus erfarenhet. I ca. 5 minuter berättade jag vem jag var, vad min studie gick ut på, och vad deltagarna skulle få göra. Sedan fick deltagarna börja teckna.

6.2 Urval

Min urvalsgrupp består av totalt 14 personer med någon typ av demenssjukdom, då jag vill ta vara på gruppens konstnärliga uttryck. För att hitta mina deltagare så gjorde jag ett *snöbollsurval,* som enligt Alan Bryman (professor inom sociala studier och organisationsstudier) är en typ av *bekvämlighetsurval* (att hitta de deltagare som finns närmast tillgängliga).[70] Snöbollsurval handlar enligt Bryman om att få kontakt med en liten grupp personer relevant för studien, som hjälper till att få kontakt med fler deltagare.

För att kunna hitta deltagare med demenssjukdomar så kontaktade jag flera gruppboenden för demenssjukdomar. Då jag var bosatt på Gotland under arbetets gång så kontaktade jag specifikt de boenden som fanns på ön, vilket gör det till ett bekvämlighetsurval. Efter att jag fick kontakt med två boenden så valde verksamhetscheferna ut de deltagare som hade möjlighet att delta i studien. Här utvecklas bekvämlighetsurvalet till ett snöbollsurval enligt Brymans beskrivningar, då en grupp personer (cheferna på boendena) gav mig tillgång till mina deltagare (personerna med demens).[71]

[68] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, sid. 12-13.
[69] Cousineau, *Art & Seniors*, 13 april 2026.
[70] Alan Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder (Originaltitel: Social Research Methods, Third Edition)* (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2018, sid. 194-196.
[71] Ibid.

6.3 Etik

I min studie arbetar jag med människor med demenssjukdomar, som innebär olika typer av nedsatt kognitiv förmåga. De kognitiva svårigheterna innebär problem med minne och rörlighet, vilket innebär att jag har behövt lägga ett extra stort fokus på den etiska aspekten. Därför har jag riktat mig till Vetenskapsrådets skrift *God forskningssed 2024*, som via ALLEA-kodexen tar fram fyra principer för forskning som involverar människor; *tillförlitlighet*, *ärlighet*, *respekt* och *ansvar*.[72] *Tillförlitlighet* handlar om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket jag gör genom att ge en introduktion om mig själv och mitt lärosäte. *Ärlighet* handlar om att genomföra, granska och informera forskning på ett rättvist och objektivt sätt. Detta säkerställer jag via samtyckesblanketter, och ger deltagare och anhöriga information om studiens utförande och behandling av personuppgifter. *Respekt* handlar om hur berörda subjekt behandlas. Jag måste se till att deltagarna känner sig trygga, inte får personuppgifter läckta, och kan dra sig ur närsomhelst. *Ansvar* handlar om att föra forskningen från idé fram till publicering, och dess vidare konsekvenser. Jag kommer se till att min studie utförs rättvist rakt igenom, och tar ansvar för eventuella problem som uppkommer.

6.3.1 Samtycke

Jag behövde vara tydlig med att mina potentiella deltagare blev informerade om vad min studie går ut på. Information och samtycke kring en studie är enligt Vetenskapsrådet en grundläggande princip för forskningsetik, och lägger fram flera kriterier.[73] Samtycket ska vara *informerat*, vilket jag gav via samtyckesblanketter med information kring studiens syfte, utförande och hantering av personuppgifter. Samtycket ska även vara *frivilligt* enligt Vetenskapsrådet, vilket innebär att jag inte får tvinga eller övertala någon att delta i min studie. Informationen måste vara *specifikt* avgränsad, så min beskrivning av studien visar exakt vad personen samtycker till. Samtycket måste godkännas *uttryckligt och otvetydigt*, vilket gjordes via en underskrift (samt namnförtydligande) i min blankett tillsammans med datumet då den utfördes. Samtycket måste vara *möjligt att återta*, och jag lade därför fram att personen kan dra sig ur närsomhelst. Och slutligen måste samtycket vara *dokumenterat* och sparas på ett lämpligt sätt, och jag såg därför till att spara de påskrivna blanketterna på ett säkert ställe.

6.3.2 Etik kring personer med demens

Trots de tydliga riktlinjerna så ställdes jag inför etiska prövningar, då studien gäller just personer med demens. Innan jag utförde studien så kunde jag inte veta vilket demensstadium varje deltagare befann sig i, vilket gjorde det osäkert huruvida varje deltagare kunde ge sitt eget samtycke. Jag läste vidare om samtycke på Vetenskapsrådets webbplats, som menar är det acceptabelt att frångå de ordinarie kriterierna om samtycke inte kan inhämtas.[74] Framför

[72] Vetenskapsrådet, *God forskningssed 2024*,https://www.vr.se/download/18.4c9f221a191e4edf9053a474/1727853946433/God%20forskningssed%20VR%202024.pdf, 2 juni 2026, sid. 11.
[73] Vetenskapsrådet, *God forskningssed 2024,* sid. 62.
[74] Vetenskapsrådet, *God forskningssed 2024,* sid. 64.

allt gäller detta om "riskerna är små, det förväntade värdet är högt, eller hindren för att hämta in samtycke är stora".[75] Detta tog jag mig an genom att följa etikprövningslagen som tagits fram av Utbildningsdepartementet i Sveriges Riksdag, under kapitlet "Forskning utan samtycke" mellan 20-22 §§.[76] I 20 § står det att forskning får utföras utan samtycke ifall exempelvis sjukdom eller psykisk störning hindrar att en persons mening inhämtas. Dock får forskningen endast ske under förutsättningarna i nästkommande paragrafer, menar Utbildningsdepartementet.

Den följande paragrafen, 21 §, menar att forskning avseende en person som inte kan ge eget samtycke får utföras ifall det kan ge kunskap som inte är möjlig via forskning med samtycke, och om det kan leda till direkt nytta för personen.[77] Min studie förväntas ge en kunskap kring bildpedagogiskt arbete med demens: en sjukdomstyp som kan göra att samtycke inte är möjligt. Däremot är inte syftet med min studie att vara till direkt nytta för deltagarna, utan på ett långsiktigt plan för arbete kring bildpedagogik och demenssjukdomar. Utbildningsdepartementet menar dock att forskningen ändå får utföras om syftet är att bidra till ett resultat som kan vara till nytta för personen eller någon med samma eller liknande sjukdom, och om det innebär obetydlig risk för skada och obehag för personen.[78] Min studie syftar till att underlätta konstnärligt arbete och lyfta stigmat kring demenssjukdomar, vilket gör studien till nytta för alla personer med sjukdomarna. Min studie är också utformad för obetydlig skaderisk och obehag för mina deltagare, då den innebär fritt konstnärligt skapande med en typ av dokumentation som inte stör deltagarna. I 22 § står det att en person som inte kan ge eget samtycke så långt möjligt ska informeras personligen om forskningen, och att samråd ska ske med personens närmaste anhöriga, och med god man eller förvaltare om frågan ingår i deras uppdrag.[79] Ifall mina potentiella deltagare inte kunde ge eget samtycke, så hade jag därmed underlag att få samtycke i samråd med deras anhöriga.

Utifrån Vetenskapsrådets och Utbildningsdepartementets riktlinjer så konstruerade jag samtyckesblanketter, enligt en mall från mitt lärosäte. Blanketterna gjordes i två versioner: en som är riktad direkt till deltagarna (se bilaga 1), och en som är riktad till deltagarnas anhöriga (se bilaga 2). I blanketterna berättar jag om min studie, hur deltagarnas teckningar kommer användas, och att allt material anonymiseras. I blanketterna beaktar jag också varje deltagares rätt att dra sig ur studien närsomhelst. På baksidan av varje blankett finns ett formulär för underskrift, namnförtydligande och datum (se bilaga 3). Jag mailade båda versionerna av blanketterna till verksamhetschefen på varje boende, som avgjorde vilka deltagare som kunde ge eget samtycke och vilka som behövde samtycke via anhöriga.

[75] Ibid, sid. 65.
[76] Sveriges Riksdag, *Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor*, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460/, 16 februari 2026.
[77] Ibid.
[78] Ibid.
[79] Ibid.

6.4 Empiri och material

Det material jag har fångat upp består av två delar; fältanteckningarna jag tog under varje workshop, och bilderna föreställande träd som deltagarna har skapat. Jag valde bort intervjuer som metod, då mina deltagares nedsatta kognitiva förmågor kunde innebära minnessvårigheter kring det som skedde under workshopen. Verksamhetscheferna berättade att flera deltagare inte ville bli inspelade, vilket gjorde att jag även valde bort att spela in varje workshop. Jag gjorde då valet att observera och anteckna, något som Tobias Olsson tar upp i sin bok *Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier*.[80]

En viktig fråga att ställa sig innan en observation, enligt Olsson, är *vad* du ska observera inom ditt valda område.[81] Det behövs en strategi för observation, då intrycken från den valda miljön annars kan bli förvirrande. Han tar därför upp strategin att göra en *schematisk karta* över den plats du observerar, där du sedan skriver ner de händelser som inträffat, när de inträffat, och de personer som varit involverade. Enligt Olsson är block och penna de viktigaste verktygen hos en kvalitativ forskare, då du kan samla de intryck som uppkommer under möten.[82] Inför varje workshop så utrustade jag mig därför med ett anteckningsblock och en bläckpenna, som blev mina främsta verktyg. Och i enlighet med Olssons strategi kring schematisk karta så skapade jag en sådan karta i mitt anteckningsblock. Eftersom jag inte visste det exakta antalet deltagare på förhand så skapade jag kartan kort innan workshopen började. Så snart alla deltagarna satte sig ner så tecknade jag en enkel modell av bordet och stolarna, och markerade på vilka stolar deltagarna satt. Varje deltagare numrerades i anteckningarna så att jag kunde ta vara på individuella uttryck utan att nämna några namn. Dessa individuella uttryck var bland annat tidpunkten när deltagaren började teckna, hur pratsam hen var, och om hen hade mycket stöd från vårdpersonalen. Som Olsson poängterar så bör du som forskare anteckna allt du finner intressant (även om du inte planerar att använda det i analysen) då mycket kan visa sig vara oväntat användbart.[83] Därför höll jag antecknandet flexibelt, och var beredd på att anteckna oförutsedda aspekter.

6.5 Metod för analys

"Data talar inte för sig själva. Det är analysens uppgift att få data att tala", som Tobias Olsson skriver i sitt kapitel om kvalitativ analys.[84] Jag kommer därför behöva hitta en lämplig analysmetod för att få min egen data att tala. I kapitlet "Att analysera kvalitativt material" i *Handbok i kvalitativa metoder,* tar Jens Rennstam (docent i företagsekonomi) och David Wästerfors (professor vid sociologiska institutionen, Lunds universitet) upp tre grundläggande arbetssätt för analysering av kvalitativt material; *sortera* (få överblick över mitt material), *reducera* (välja ut delar ur materialet) och *argumentera* (bilda min egen

[80] Olsson, *Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier*.
[81] Ibid. sid. 69.
[82] Ibid, sid. 89.
[83] Ibid, sid. 91.
[84] Ibid. sid. 97.

uppfattning om materialet), utifrån vilka jag strukturerar min egen analys.[85] För att *sortera* mitt eget material så kommer jag dela upp det i konkreta punkter baserade på mina frågeställningar (“Hur upplever personer med demens att få teckna egna träd under en workshop?*”* och “Hur kan en konstnärlig workshop för personer med demens organiseras?”). Punkterna skapas genom att jag *reducerar* materialet till de mest intressanta delarna, utifrån vad jag hittat. Och slutligen *argumenterar* jag för vad jag kommit fram till, utifrån de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen.

7. Resultat

Inspirerat av Rennstams och Wästerfors metod för analys så har jag delat upp min empiri i konkreta punkter.[86] Punkterna är *arrangerandet* (min roll som bildpedagog), *engagemanget* (deltagarnas aktivitet), *materialet* (deltagarnas val av material), och *trädens betydelse* (trädens funktion som tema). Värt att notera är att jag inte har haft full insikt i deltagarnas medicinska bakgrund, och kan därför inte avgöra huruvida det påverkade resultatet. Den första workshopen jag utförde har jag namngett “Workshop A”, och den andra "Workshop B”. Av mina totalt 14 deltagare så skapade 13 deltagare teckningar av träd, då en deltagare lämnade workshop utan att påbörja en teckning.

7.1 Arrangerandet

Varje workshop började med att personalen samlade alla deltagarna i boendets matsal. De allra flesta deltagarna satt vid ett stort bord då, med undantag för en deltagare under varje workshop. Under Workshop A satt en deltagare vid ett eget bord, då personalen menade att hen föredrog att arbeta på egen hand. Under Workshop B kunde en person inte delta av medicinska skäl, vilket gjorde att jag och personalen hjälpte hen på egen hand efter den ordinarie workshopen. Samtidigt som deltagarna samlades så placerade jag allt teckningsmaterial i mitten av det stora bordet. Jag frågade den enskilda deltagaren under Workshop A vad hen önskade för material, och gav hen materialet i fråga.

När jag introducerade varje workshop så höll jag mig till max 5 minuter, för att behålla deltagarnas uppmärksamhet. Där berättade jag vem jag var, vad min studie gick ut på, och vad deltagarna skulle få göra. Även om ett par deltagare under varje tillfälle pratade under tiden så behöll de flesta uppmärksamheten, och verkade inte rastlösa eller ofokuserade. Direkt efter introduktionen fick deltagarna börja teckna. Medan deltagarna tecknade så antecknade jag mina observationer, och gick ett par gånger till varje deltagare och frågade hur det gick. Min plan var att hålla varje workshop under en timme, samtidigt som jag var öppen för att förlänga eller förkorta den beroende på deltagarnas aktivitet. Varje workshop fick därför inget officiellt avslut, utan avslutades när den sista deltagaren kände sig klar. Workshop A pågick mellan kl. 13.00–14.30, en halvtimme längre än planerat då några av

[85] Jens Rennstam & David Wästerfors, “Att analysera kvalitativt material”, i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022.
[86] Ibid.

deltagarna ville fortsätta på sina teckningar. Workshop B pågick mellan kl. 13.45–14.45 under den planerade tidsramen, då den sista deltagaren kände sig klar efter en timme.

Då en person inte kunde delta under Workshop B så skapade jag ett eget upplägg för deltagaren. Jag och en från personalen besökte deltagarens rum, och tog med oss ett A3-papper samt de färgade papperslapparna jag hade förberett. Där beskrev jag kort vad uppgiften gick ut på, och så kommunicerade deltagaren hur lapparna skulle placeras på papperet. Vi höll på i totalt 15 minuter, tills deltagaren kände sig nöjd med trädet hen skapat av papperslapparna (se bild 1).



Bild 1: Deltagares teckning av träd, som skapades med hjälp av färgade papperslappar.

7.2 Engagemanget

I denna punkt har jag inspirerats av Philip E. Sauers med kollegors studie kring konstprojektet OMA, där forskarna delade upp deltagarnas agerande i olika domäner som sedan mättes statistiskt.[87] En av dessa domäner var just *engagemang*, och syftar enligt forskarna på hur fokuserad deltagaren är och hur mycket stöd hen söker från andra personer i rummet. Därför skrev jag upp tidpunkten när varje deltagare började teckna, hur länge hen arbetade på sin teckning, och hur mycket stöd hen sökte från omgivningen. Ungefär hälften av deltagarna behövde cirka 10 minuter på sig att komma igång med tecknandet. Andra

[87] E. Sauer; Fopma-Loy; M. Kinney & Lokon, “”It makes me feel like myself”: Person-centered versus traditional visual arts activities for people with dementia”, sid. 7.

hälften kom igång inom 5 minuter. En deltagare var med under introduktionen av Workshop B, men lämnade salen utan att ha påbörjat någon teckning. Hen deltog dock aktivt i diskussioner och samtal. Övriga deltagare i båda workshops arbetade med sina teckningar i minst 5 minuter, vilket enligt Philip E. Sauers med kollegors studie innebär att de visade ett engagemang.[88] Ett annat kriterium för engagemanget, enligt E. Sauer m.fl., var hur mycket stöd varje deltagare sökte från andra personer i rummet. De allra flesta deltagarna i min studie sökte inte självmant efter stöd, utan personalen och jag frågade istället hur det gick, så valde deltagarna därefter om de behövde hjälp eller inte.

Jag antecknade också hur ofta samtal uppstod, då jag under mina workshops märkte att samtalsnivån varierade. Under båda mina workshops var samtalsnivån högre i början av varje workshop, för att sedan minska när deltagarna kom igång med tecknandet. Under Workshop A var samtalsnivån hög i början, men minskade mycket 10 minuter in. Samtalsnivån var fortsatt låg under resten av tiden. Under Workshop B var det mer samtal, vilket berodde på att personalen aktiverade deltagarna med hjälp av konversationer. Under samma workshop valde en anhörig samt några från personalen även att teckna tillsammans med deltagarna, för att aktivera dem. En av deltagarna påbörjade aldrig någon teckning, men deltog aktivt i diskussioner under workshopens gång. Trots det var samtalsnivån ändå relativt låg under Workshop B, då deltagarna mestadels var fokuserade på tecknandet.

7.3 Materialet

I den tidigare forskningen hittade jag ett kunskapsglapp kring vilken typ av konstnärligt material som bäst passar personer med demens. Och då det konstnärliga materialet hade en betydande roll i varje workshops utformning och deltagarnas upplevelser, så har jag valt att sammanställa deltagarnas val av material i två tabeller. Det har jag gjort genom att analysera de färdigställda teckningarna, som skapats av de 12 deltagare som deltog under varje ordinarie workshop, och vilken typ av material de använde i sin teckning. Deltagaren som skapade trädet av färgade papperslappar har jag inte tagit med här, då materialet var valt på förhand.

Tabell 1.

Material	**Tusch**	**Kritor**	**Blyerts**
Workshop A	3	5	1
Workshop B	3	4	5
Totalt	6	9	6

Tabell 2.

Färger	**Enfärgat motiv**	**Flerfärgat motiv**

[88] Ibid.

Workshop A	2	5
Workshop B	1	4
Totalt	3	9

Utifrån tabell 1 kan jag konstatera att kritor var det mest valda materialet, med tusch och blyerts på delad andraplats. Utifrån tabell 2 så valde de allra flesta deltagarna att arbeta med mer än en färg i sin teckning.

7.4 Trädens betydelse

I den tidigare forskningen hittade jag ett kunskapsglapp kring hur personer med demens upplever att få teckna egna träd. I denna punkt tar jag därför bland annat vara på samtalen som uppstod under varje workshop, då ämnet träd ofta kom upp. En deltagare hade stor kunskap kring latinska trädnamn, och lärde gärna ut dessa namn till övriga i rummet. En annan deltagare berättade om hur hen lade stort fokus på trädets silhuett och färg när hen tecknade. En deltagare påbörjade någon teckning, men visade ett stort intresse för ämnet genom att berätta om sina egna upplevelser kring träd. En av deltagarna hade svårt att komma igång då hen hade svårt att hitta inspiration. Jag visade då referensbilderna på träden och lät hen gissa namnen på de olika trädsorterna, och då kom hen direkt igång med tecknandet. Jag observerade också att flera av deltagarna använde referensbilderna genom att placera dem bredvid sig under tecknandet. En deltagare tyckte dock att bilderna var "till för stor hjälp", då det kändes för uppstyrt.

Alla mina deltagare avbildade ett motiv som kan tolkas som ett träd. En del motiv är föreställande och andra mer abstrakta, vilket gjorde det svårt att dra gränsen kring vad som är ett träd och inte. I Michelangelo Stanzani Maseratis med kollegors studie så delas dock varje tecknat träd in i beståndsdelar; krona, stam, grenar, rötter, löv och blommor.[89] De allra flesta av mina deltagares tecknade träd har en tydlig stam och grenar, och de som inte har det visar en samling med löv som bildar en krona. Tre deltagare skrev beskrivande namn på sina teckningar, som alla hade med träd att göra. Den ena deltagaren skrev "Betula" och "Pyrus", som båda är latinska namn för trädslagen "björk" och "päron" (se bild 2).[90] Den andra deltagaren döpte sitt träd till "Trädmannen", och teckningen avbildar ett träd med ansikte och armar i trädkronan (se bild 3). Den tredje deltagaren skrev "TYNNE" på sin teckning, som är ett gotländskt samlingsnamn för taggbuskarna hagtorn, slån och nyponros (se bild 4).[91]

[89] Stanzani Maserati, Matacena, Sambati, Oppi, Poda, De Matteis & Gallassi, "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment", sid. 1-6.
[90] SLU Artdatabanken - Artfakta, *Björkar Betula,* https://artfakta.se/taxa/1006019/information, 1 maj 2026; SLU Artdatabanken - Artfakta, *Päronsläktet Pyrus*, https://artfakta.se/taxa/1006578/taxonomi, 1 maj 2026.
[91] Naturvårdsfunktionen, *Ädellövskog i Grötlingbo - vegetationsbeskrivningar*, 1985, sid. 6, https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b1d393819324610c374c6ac/1732523671544/%C3%84dell%C3%B6vskog%20i%20Gr%C3%B6tlingbo.%20Vegetationsbeskrivningar.pdf, 1 maj 2026.



Bild 2: Deltagares teckning av träd, som innehåller namnen “Betula och Pyrus”



Bild 3: Deltagares teckning av träd, som namngavs “Trädmannen”



Bild 4: Deltagares teckning av träd, som innehåller namnet “TYNNE”

8. Analys och tolkning

För att tolka och analysera min empiri så har jag, inspirerat av Rennstams och Wästerfors metod för analys, reducerat mitt resultat i ytterligare punkter.[92] Jag lägger här större fokus på de aspekter som jag såg hade en betydande roll för deltagarna. Aspekterna är *bildpedagogen*, *personalen*, *materialet* samt *träden*. Genom att analysera utifrån Jonas Aspelins, Sven Perssons, och Åsa Hirshs beskrivningar av relationellt pedagogiskt perspektiv så utforskar jag relationen mellan deltagarna och bildpedagogen, deltagarna och personalen, och så vidare.[93] Och genom Roger Säljös och Maria Rubins beskrivningar av sociokulturellt perspektiv så letar jag språkliga aspekter i materialet, såsom mitt pedagogiska språk, deltagarnas språkliga reflektioner, och teckningarnas bildspråk.[94]

[92] Rennstam & Wästerfors, “Att analysera kvalitativt material”.

[93] Aspelin & Persson, *Om relationell pedagogik*; Hirsh, “Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus”.

[94] Säljö, “Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande”; Rubin, “Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap”.

8.1 Bildpedagogens roll

Genom att betrakta arrangerandet av mina workshops genom den mellanmänskliga sfären, så blev relationerna mellan deltagarna och mig som bildpedagog påtagliga.[95] Arrangemanget av varje workshop gick smidigt, men innebar också en stor flexibilitet för mig som inte kände deltagarna på förhand. Likväl så kände inte deltagarna mig innan. Jag introducerade varje workshop under ca. 5 minuter, och berättade vem jag var, vad min studie gick ut på, samt vad deltagarna skulle få göra under workshopen. Då de allra flesta deltagarna (förutom några som pratade under varje introduktion) inte upplevdes uttråkade, så tycktes varje introduktion vara i god längd och tillräckligt informativ för att starta workshopen, vilket tyder på en påbörjat god relation mellan mig och deltagarna. Även om bildpedagogen Sinthia Cousineau rekommenderade att deltagarna skulle sitta i mindre grupper för att underlätta interaktioner sinsemellan, så fungerade det att samla alla vid ett bord.[96] För mig som bildpedagog underlättade det dels för att jag kunde kommunicera med alla deltagare när jag introducerade workshopen, och dels för att jag kunde placera allt material vid mitten av bordet. Dessutom uppstod flera samtal mellan deltagarna som gjorde att de fick motivation, vilket också tyder på mellanmänskliga relationer mellan deltagarna själva.[97]

Med detta sagt så arbetade några deltagare bättre enskilt. Under Workshop A placerade personalen en deltagare vid ett eget bord, då de visste på förhand att hen jobbade bättre på egen hand. Jag frågade deltagaren vad hen önskade för material, och gav det utifrån hens önskemål. Under Workshop B kunde en deltagare inte delta av medicinska skäl, så jag och en från personalen besökte deltagarens rum och lät hen skapa ett träd med hjälp av färgade papperslappar. I båda fallen blev de mellanmänskliga relationerna påtagliga, där jag och deltagarna skapade ett samarbete.[98] Genom ett sociokulturellt perspektiv så kunde jag här också anpassa mitt språk utifrån det jag visste om varje deltagare, och resultatet blev att båda deltagarna kunde skapa varsin teckning av träd, utifrån sina egna förutsättningar.[99]

Rhea Young med kollegor utförde en studie kring konstens inverkan på talspråket och minnet hos personer med demens, och resultatet visade på att skapande av konst kan minska talsvårigheterna hos målgruppen.[100] Under mina workshops märkte jag dock ingen skillnad i talsvårigheter hos deltagarna, inte minst då deltagarna blev tystare ju mer fokuserade de var på tecknandet. Den dialogbaserade konstpedagogik som Max Liljefors och Åsa Alftberg tog upp i sin forskningsrapport om konstvandringarna på Nacka sjukhus har jag dock kunnat använda mig av i mina workshops.[101] Dialogbaserad konstpedagogik handlar om att pedagogen är öppen för patienternas egna tolkningar och åsikter istället för att enbart prata

[95] Hirsh, "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus".
[96] Cousineau, *Art & Seniors*.
[97] Aspelin & Persson, *Om relationell pedagogik*.
[98] Ibid.
[99] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande"; Rubin, "Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap".
[100] Young, Tischler, Hulbert & M. Camic, "The impact of viewing and making art on verbal fluency and memory in people with dementia in an art gallery setting".
[101] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*.

själv. Under mina workshops var jag öppen för deltagarnas berättelser, och fick bland annat lära mig om deltagarnas konstnärliga processer, olika träds namn på latin, och att flera deltagare hade arbetat inom skogsbruk och lantbruk. Genom att betrakta den dialogbaserade konstpedagogiken genom ett sociokulturellt perspektiv, så anpassade jag mitt språk så att deltagarnas språk också fick höras.[102] Under varje workshop gick jag ett par gånger till varje deltagare, och frågade hur det gick. Vissa deltagare ansåg att det gick bra, och berättade om sina processer eller erfarenheter av träd. Genom att jag öppnade upp för samtal så lät jag deltagarnas berättelser ta plats, och anpassade på så vis mitt språk. Andra deltagare behövde hjälp med att komma igång. Exempelvis så hade en deltagare svårt att komma igång med tecknandet, och jag visade då referensbilderna av träden. Genom att låta deltagaren gissa namnen på de olika trädsorterna så fick hen inspiration och började teckna, vilket gjorde det språkliga utbytet betydande.

Den planerade tidsramen för varje workshop var 1 timme, både i samråd med cheferna och enligt Emily Shoesmiths m.fl och Philip E. Sauers m.fl. studieresultat.[103] Denna ram var lämplig att hålla, då många deltagare blev trötta fort samtidigt som flera stannade kvar längre. Genom ett relationellt pedagogiskt perspektiv så kan jag se att tiden för varje workshop kontextuellt anpassades till deltagarnas behov, då Workshop A pågick en halvtimme längre än planerat, eftersom flera deltagare ville fortsätta med sina teckningar.[104] Något som jag fick höra av personalen på båda boendena var att de flesta deltagarna var piggare tidigt på dagen. Det är en förklaring till att många blev trötta fort under varje workshop, eftersom båda pågick under eftermiddagar (då det passade bäst i båda boendenas dagsschema).

8.2 Vårdpersonalens roll

Genom ett relationellt pedagogiskt perspektiv så kan jag se att relationen mellan deltagarna och personalen var av stor betydelse.[105] Under mina workshops så kände jag inte mina deltagare på förhand, vilket gjorde att jag som bildpedagog var tvungen att ha ett flexibelt arbetssätt. Deltagarnas humör kunde skifta under workshopen, då några hade svårt att komma igång med att teckna och/eller blev trötta fort och ville lämna rummet. Här hade jag stor behållning av personalen som redan kände deltagarna. Till att börja med så kunde verksamhetscheferna välja ut de deltagare som hade bäst förutsättningar att delta, vilket jag själv inte hade kunnat göra. Sedan kunde personalen aktivera deltagarna under själva workshopen, genom att föra samtal med dem, eller att personalen själv tecknade för att inspirera deltagarna. Även här blev workshopen en mellanmänsklig sfär där relationer skapades, när både personal och personer med demens fick rollen som deltagare.[106]

[102] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande"; Rubin, "Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap".
[103] Ibid; E. Sauer, Fopma-Loy; M Kinney & Lokon, ""It makes me feel like myself".
[104] Aspelin & Persson, *Om relationell pedagogik*; Hirsh, "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus".
[105] Ibid.
[106] Ibid.

Från ett etiskt perspektiv blev detta en slags "icke-mänsklig relation" på grund av den information personalen hade om deltagarnas bakgrund.[107] Men från ett sociokulturellt perspektiv innebar det också att personalen kunde anpassa sitt språk efter kontexten, då de redan kände till deltagarna och deras sjukdomsstadium.[108] Därmed så kunde personalen utnyttja denna "icke-mänskliga relation" för att ge deltagarna bättre förutsättningar under varje workshop, och även hjälpa mig som utomstående bildpedagog.

8.3 Materialets roll

Enligt mina resultat tecknade majoriteten av deltagarna sina bilder delvis eller helt med färgkritor. En av pedagogerna i Emily Shoesmiths m.fl intervjuer avrådde från att använda färgkritor, då dessa kan upplevas som "barnsliga".[109] Från ett relationellt pedagogiskt perspektiv så kan jag därför se färgkritorna ur en etisk synpunkt, då de handlar om deltagarens integritet.[110] Men i min studie så var färgkritor det mest valda materialet och tycktes alltså fungera ur ett etiskt perspektiv, vilket är värt att ta med till framtida studier och undervisningssammanhang för personer med demens. Det övriga materialet, som var tuschpennor och blyertspennor, användes av något färre deltagare. Jag noterade att några av mina deltagare hade svårt att ta av korkarna på tuschpennorna och behövde hjälp med det, vilket kan ha bidragit till att färre använde pennorna. Genom ett sociokulturellt perspektiv så kan jag via bildspråket också se att den absoluta majoriteten använde mer än en färg i sina bilder.[111] Det tyder på att de flesta av deltagarna hade färgseende, och kan vara en anledning till att något färre deltagare använde blyertspennor då materialet endast ger möjligheter att arbeta i gråskala. Utbudet av material är därmed betydande i ett språkligt sammanhang, då det avgör hur deltagarna får möjlighet att uttrycka sig via bildspråk.[112]

8.4 Trädens roll

I Geoffrey H. Donovan med kollegors långtidsstudie kring hur plantering påverkar människors hälsa så var effekterna positiva, och innebar en minskning av dödsfall hos personer över 65 år.[113] Dessa effekter går dock inte att bevisa i min egen studie, då den utfördes under mycket kortare tid. Däremot gav den mig goda underlag att använda temat med träd i mina workshops, och temat var uppskattat från flera deltagare. I Max Liljefors och Åsa Alftbergs rapport följde forskarna med på en konstvandring av utställningen *Träd* av Maria Boij, och där visade sig träd vara ett motiv som öppnade upp för reflektioner och

[107] Säfström, *Skillnadens pedagogik*, sid. 77.
[108] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande" sid. 77.
[109] Shoesmith, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration", sid. 13-14.
[110] Hirsh, "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus"; Säfström, *Skillnadens pedagogik*, sid. 77.
[111] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande"; Rubin, "Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap".
[112] Ibid.
[113] Donovan, Prestemon, Gatziolis, Michael, Kaminski & Dadvand, "The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis", sid. 1-7.

tolkningar.[114] Det stämmer även in på min studie, då flera av deltagarna visade ett stort intresse för ämnet. Från ett sociokulturellt perspektiv kan jag se att träden blev ett slags språk, som lärdes ut mellan mig och mina deltagare.[115] Bland annat hade en deltagare stor kunskap kring latinska trädnamn, och lärde gärna ut dessa namn till övriga i rummet. En annan deltagare hade svårt att komma igång med tecknandet, men när hen fick gissa träden på referensbilderna så fick hen inspiration.

I både Michelangelo Stanzani Maseratis med kollegors studie kring The Tree-Drawing Test (TDT), och Christine Isakssons med kollegors studie kring hur patienter använde självbilder i målningar av träd, och resultaten visar att träd är ett lämpligt motiv för personer med demens att teckna.[116] Det stämmer även in på min studie, då alla mina deltagare avbildade ett motiv som kan tolkas som ett träd. Från ett sociokulturellt perspektiv blir det tydligt att träden kan ses som ett språk i både bild- och textform, då några av mina deltagare hade specifika reflektioner kring sina teckningar.[117] En av mina deltagare berättade specifikt om hur hen lade stort fokus på trädets silhuett och färg, en annan skrev latinska trädnamn på sin teckning, och en tredje gjorde ett träd med mänskliga drag som hen döpte till "Trädmannen" genom att skriva det på teckningen.

Faktumet att min studie ägde rum på Gotland innebär också intressanta tolkningar. Från ett relationellt pedagogiskt perspektiv så kunde flera deltagare sägas ha en tidigare relation till träd, då flera hade en bakgrund som involverade träd på något sätt, till exempel arbete inom skogsbruk och lantbruk. Även om jag inte kände till deltagarnas geografiska bakgrund så är det värt att nämna att år 2020 var Gotland det län med näst mest jordbruksmark (efter Skåne) med sina 111 846 hektar, vilket innebär 35% av Sveriges yta.[118] Andelen skogsmark låg på 138 000 hektar samma år, vilket är en lägre andel av landets totala skogsmark, men innebär att Gotland har mer skog än jordbruksmark.[119] Gotland är alltså rikt på träd, vilket kan ha bidragit till att mina deltagare tycks ha uppskattat temat kring träd. En deltagare skrev dessutom "TYNNE" på sin teckning, som är ett gotländskt samlingsnamn för taggbuskarna hagtorn, slån och nyponros.[120] Genom ett sociokulturellt perspektiv kan den specifika namngivningen på teckningen ses som en slags representation för Gotland, då språket här blir ett verktyg för att representera ett län i Sverige.[121]

---

[114] Liljefors & Alftberg, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, sid. 14-16.

[115] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande", sid. 67-85.

[116] Stanzani Maserati, Matacena, Sambati, Oppi, Poda, De Matteis & Gallassi, "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment"; Isaksson, Norlén, Englund & Lindqvist, "Changes in self-image as seen in tree paintings".

[117] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande", sid. 67-85.

[118] SCB, *Marken i Sverige*, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/marken-i-sverige/, 6 mars 2026.

[119] SCB, *Markanvändningen i Sverige 2020*, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-bebyggelse-och-mark/markanvandning/markanvandningen-i-sverige/pong/tabell-och-diagram/markanvandningen-i-sverige/, 6 mars 2026.

[120] Naturvårdsfunktionen, *Ädellövskog i Grötlingbo - vegetationsbeskrivningar*, 1985, sid. 6, https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b1d393819324610c374c6ac/1732523671544/%C3%84dell%C3%B6vskog%20i%20Gr%C3%B6tlingbo.%20Vegetationsbeskrivningar.pdf, 1 maj 2026.

[121] Säljö, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande"; Rubin, "Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap".

Ett intressant begrepp som nämndes av en deltagare var *vårdträd*. I boken *Vårdträdets visdom: svenska vårdträd i folktro och tradition* tar Eva Carlsson Werle upp begreppet, och menar att det syftar på ett större träd på en gård.[122] Trädet är menat att föra tur med sig, antingen genom att själv agera väktare eller genom att ge husrum åt en skyddsande. Carlsson Werle konstaterar att vårdträd inte är lika vanliga i dagens Sverige, och teoretiserar att det beror på minskat jordbruk och minskad folktro hos befolkningen. Gotlands stora andel jordbruksmark, kombinerat med att vårdträd var vanligare förr i tiden, gör det alltså möjligt att flera av mina deltagare har någon slags koppling till dessa. Kanske planterade de sitt eget vårdträd under mina workshops, och såg det som en beskyddare?

9. Gestaltande arbete

Som del av det självständiga arbetet har jag gjort ett gestaltande arbete kopplat till min studie. Idén till arbetet växte fram i samband med att jag började planera min studie och bestämde mig för att fokusera bildpedagogiskt på personer med demenssjukdomar. Ju mer jag läste på om demens så upptäckte jag att det finns ett stigma mot sjukdomarna. För att lyfta stigmat så ville jag göra ett konstnärligt projekt för personer med demenssjukdomar, vilket utvecklades till mina workshops. Då jag ville ge personerna en chans att synas så fick jag idén att göra konstprojektet till mitt gestaltande arbete. Jag lät deltagarna i min studie teckna egna träd, då träd har enkla men igenkännliga former som ändå går att variera stort, och därför kan passa personer med nedsatta kognitiva förmågor. Symboliskt så kunde träden även representera en skog, när alla teckningar samlades.

Min ursprungliga plan var att enbart fokusera på personer med demenssjukdomar och ta med deras teckningar i det gestaltande arbetet. Men då jag upptäckte hur mycket vårdpersonalen aktiverade deltagarna genom att bidra till samtalen och själva teckna med dem, så bestämde jag mig för att även ta vara på deras bidrag. Personalens teckningar togs inte med i analysen, då mitt syfte och mina frågeställningar fokuserar på personer med demens, men de fick ändå synas i mitt gestaltande arbete.

Efter att jag färdigställt mina workshops så scannade jag deltagarnas bilder digitalt. Jag retuscherade bort signaturer från bilderna för att hålla dem anonyma, men behöll all övrig text. Jag har även digitalt höjt kontrasten på alla bilder, för att de ska synas bättre i mindre format. Jag sammanställde sedan teckningarna både i form av ett bildspel och ett digitalt collage (se bild 5). I bildspelet visades varje bild enskilt, medan collaget visade alla träd samtidigt. I mitt slutgiltiga arbete så presenterades bildspelet på en väggmonterad bildskärm, medan bilden skrevs ut i A2-format och monterades på väggen parallellt med bildskärmen. Arbetet ställdes ut under Konstfacks Vårutställning 2026 (se bild 6).

[122] Eva Carlsson Werle, *Vårdträdets visdom: svenska vårdträd i folktro och tradition*, Stockholm: Carlsson, 2023.



Bild 5: Collaget där de tecknade träden sammanställdes digitalt, skrevs ut på ett A2-ark, och ställdes ut under Konstfacks Vårutställning.

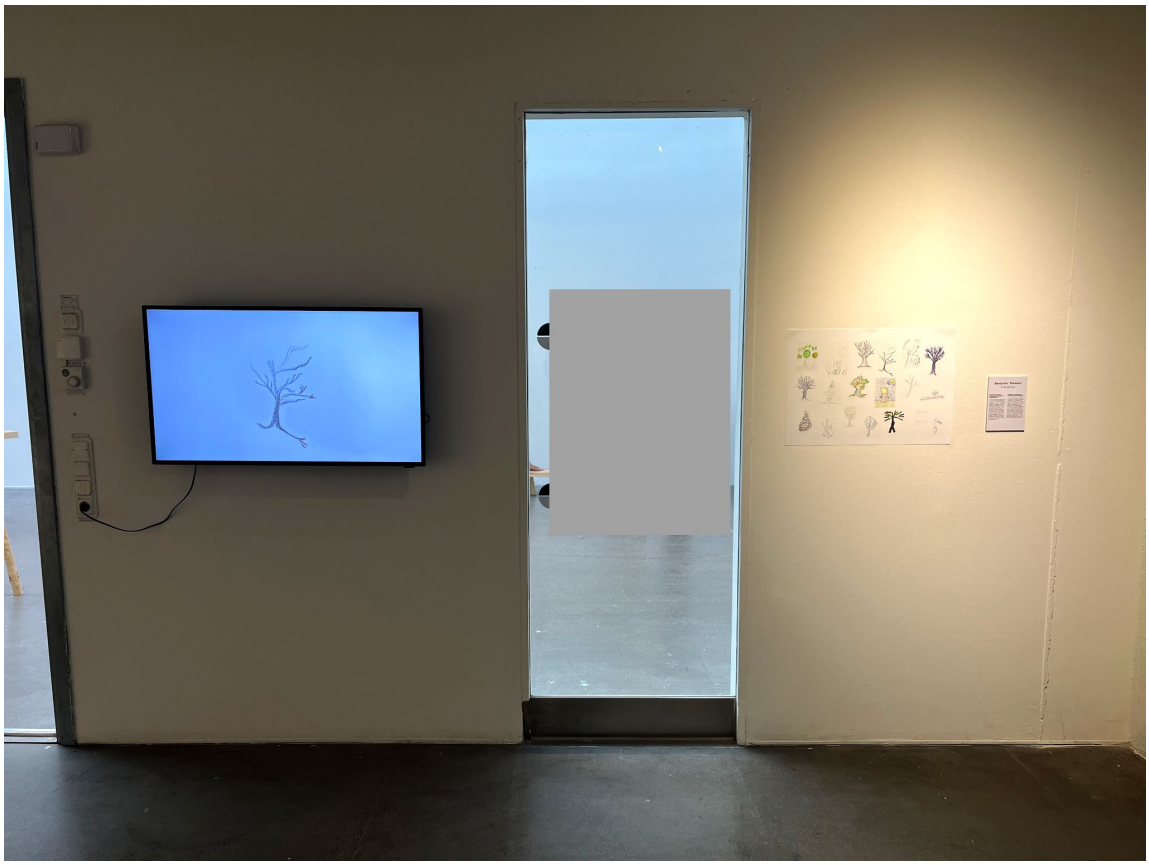


Bild 6: Mitt gestaltande arbete i helhet under Konstfacks Vårutställning 2026, med bildskärmen till vänster och collaget samt verkstext till höger (den gråa rutan i mitten är en person som censurerats).

10. Slutdiskussion

Från resultatet av min studie har jag lärt mig att en bildpedagog för personer med demens bör vara anpassningsbar, lyhörd, och ta hänsyn till en stor variation av förutsättningar. En workshop för målgruppen bör hållas tidigt på dagen (helst innan eftermiddagstid) för att deltagarna ska vara maximalt aktiva. En timme per workshop är en lämplig tidsram som samtidigt kan hållas flexibel. Om workshopen utförs på ett äldre- eller demensboende är köket en plats där bildpedagogen lätt kan samla deltagarna. Träd är ett ämne som personer med demens kan ha personliga kopplingar till och kan avbilda tack vare träds enkla men varierande utformningar. Det kan dock vara fördelaktigt att ha referensbilder på träd nära till hands, för att ge deltagarna något att utgå ifrån. Färgkritor, tuschpennor och blyertspennor är alla lämpliga teckningsmaterial för personer med demens, och beroende på deltagarnas kognitiva svårigheter kan färgade papperslappar vara ett alternativt material. Att ge deltagarna möjlighet att arbeta i färg är viktigt för att främja bildspråket. Och om bildpedagogen inte känner deltagarna på förhand så är det fördelaktigt om vårdpersonal kan vara behjälpliga med att samla och kommunicera med deltagarna.

Min studie har dock några begränsningar. Bland annat gjorde jag aldrig några intervjuer på grund av deltagarnas varierande kognitiva svårigheter, vilket medförde att jag inte fick en direkt inblick av deras upplevelser av mina workshops. Jag gjorde heller inga ljud- eller filminspelningar utifrån deltagarnas preferenser, vilket i sin tur medförde att min empiri begränsades till observationsanteckningar och deltagarnas teckningar. Därför kan det behövas närmare forskning kring personer med demens och deras egna upplevelser av att delta i en konstnärlig workshop, vilket kan göras genom att intervjua deltagarna efter varje workshop. Om möjlighet finns så kan framtida forskning använda sig av inspelningar under workshops för målgruppen, för att ta vara på fler aspekter i empirin. Det skulle även kunna göras forskning kring huruvida bildpedagogik för personer med demens och elever i grundskola eller gymnasium skiljer sig; vilka likheter och skillnader finns, och hur kan pedagogiken anpassas beroende på målgrupp?

Jag tror att resultatet av min studie kommer kunna användas för att arrangera konstnärliga vardagsaktiviteter för personer med demens, och riktas därför åt både anhöriga, vårdpersonal och aktivitetsansvariga. Då det finns ett påtagligt stigma kring demens så hoppas jag även att studien kan öka samhällets vetskap kring sjukdomarna. På ett rent pedagogiskt plan så tror jag att studien också kan användas i skolmiljöer, för att skapa workshops som är anpassade till elevers olika förutsättningar. Likväl tror jag att min studie kan belysa trädets betydelse som tema i alla typer av konstnärliga workshops, oavsett vilken målgrupp det gäller.

11. Källförteckning

Ahrne, Göran & Svensson, Peter, "Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022.

Alzheimer Society Saskatchewan, *Meaningful Activity*, https://alzheimer.ca/sites/default/files/documents/Meaningful-activity-booklet_Alzheimer-Society-of-Saskatchewan.pdf, 14 april 2026.

Aspelin, Jonas & Persson, Sven, *Om relationell pedagogik*, Gleerups Utbildning AB: Malmö, 2011.

Bryman, Alan, *Samhällsvetenskapliga metoder (Originaltitel: Social Research Methods, Third Edition)* (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2018.

Boyce, Martin, *from 'Our Love is Like the Flowers, the Rain, the Sea and the Hours' [installation]*, Tate, 2002. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/boyce-from-our-love-is-like-the-flowers-the-rain-the-sea-and-the-hours-t12132, 21 april 2026.

Carlsson Werle, Eva, *Vårdträdets visdom: svenska vårdträd i folktro och tradition*, Stockholm: Carlsson, 2023.

Cousineau, Sinthia, *Art & Seniors*, https://www.sinthiacousineau.com/art-education--older-adults.html, 13 april 2026.

Coventry, Keith, *Burgess Park SE5, Planted 1983, Destroyed 1988 [bronsskulptur]*, Tate, 1994. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-concrete-cabin-p11479, 21 april 2026.

Dementia UK, *Dealing with the stigma of dementia*, https://www.dementiauk.org/information-and-support/living-with-dementia/dealing-with-stigma/, 8 april 2026.

Doig, Peter, *Concrete Cabin [djuptryck],* Tate, 1996. Tillgänglig via: https://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-concrete-cabin-p11479, 21 april 2026.

Donovan, Geoffrey H.; Prestemon, Jeffrey P.; Gatziolis, Demetrios; Michael, Yvonne L.; Kaminski, Abigail R. & Dadvand, Payam, "The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis", *Environment Internationa*l, 170, 2022, sid. 1-7, DOI:10.1016/j.envint.2022.107609.

Eriksson-Zetterquist, Ulla, "Mixed methods", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022.

Fancourt, Daisy & Finn, Saoirse, *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*, World Health Organization, 2019, https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/e1cc8536-773d-446f-9822-8ae376f41415/content.

Hallgren, Eva & Jacquet, Ewa, *Stärk pedagogiken med estetiken: drama, bild och muntligt berättande i tematisk undervisning*, Studentlitteratur AB: Lund, 2023.

Hirsh, Åsa, "Relationell pedagogisk teori – med relationer i fokus", i *Vetenskapliga teorier för lärare*, redigerad av Margareta Serder & Anna Jobér, Stockholm: Natur & Kultur, 2021.

Hjärnfonden, *Vad är Alzheimers sjukdom?*, https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnos/alzheimers-sjukdom/vad-ar-alzheimers-sjukdom/, 2 februari 2026.

Hjärnfonden, *Vad är demens och demenssjukdom?*, https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnos/demens/vad-ar-demens/, 2 februari 2026.

Hydén, Lars Krister & Rahman, Atiqur, "Dementism och ålderism", i *Perspektiv på ålderism*, redigerad av Håkan Jönson, Lund: Social Work Press, 2021.

Isaksson, Cristine; Norlén, Ann-Katrin; Englund, Birgitta &
Lindqvist, Rafael, "Changes in self-image as seen in tree paintings", *The Arts in Psychotherapy*, 36(5), 2009, sid. 304–312, DOI:10.1016/j.aip.2009.07.004.

Israel, Joachim, *Martin Buber - Diagnosfilosof och sionist*, Stockholm: Natur & Kultur, 1992.

Karolinska Institutet, *Antalet demenssjuka och kostnader för demenssjukdomar i Sverige 2023*, https://news.ki.se/media/150869/download, 16 februari 2026.

Lalander, Philip, "Observationer och etnografi", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022.

Liljefors, Max & Alftberg, Åsa, *Konst som resurs i geriatrisk vård: Rapport från ett följeforskningsprojekt om 'Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus'*, Kulturförvaltningen: Region Stockholm, 2019, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1410160/FULLTEXT01.pdf.

Naturvårdsfunktionen, *Ädellövskog i Grötlingbo - vegetationsbeskrivningar*, 1985, sid. 6, https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1b1d393819324610c374c6ac/1732523671544/%C3%84dell%C3%B6vskog%20i%20Gr%C3%B6tlingbo.%20Vegetationsbeskrivningar.pdf, 1 maj 2026.

Olsson, Tobias, *Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier*, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2008.

Puurveen, Gloria; M. Cox, Susan; Damiano, Natasha; Neale Furneaux, Heather & Pineda Sierra, Samantha, "Co-creating an Art Exhibition on Living Well With Dementia", *AMA Journal of Ethics*, 24(7), 2022, sid. 622-633, DOI:10.1001/amajethics.2022.622.

Rennstam, Jens & Wästerfors, David, "Att analysera kvalitativt material", i *Handbok i kvalitativa metoder*, redigerad av Göran Ahrne & Peter Svensson (Tredje upplagan), Stockholm: Liber, 2022.

ResearchGate, *Profile: Geoffrey H. Donovan*, https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey-Donovan, 10 april 2026

ResearchGate, *Profile: Michelangelo Stanzani Maserati*, https://www.researchgate.net/profile/Michelangelo-Stanzani-Maserati, 10 april 2026.

Rubin, Maria, "Språk, samspel och lärande: sociokulturella teorier – språket, lärarens främsta redskap", i *Vetenskapliga teorier för lärare*, redigerad av Margareta Serder & Anna Jobér, Stockholm: Natur & Kultur, 2021.

Sauer, Philip E.; Fopma-Loy, Joan; Kinney, Jennifer M. & Lokon, Elizabeth, ""It makes me feel like myself": Person-centered versus traditional visual arts activities for people with dementia", *Dementia,* 0(0), 2014, sid. 1-18, DOI:10.1177/1471301214543958.

SCB, *Markanvändningen i Sverige 2020*, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-bebyggelse-och-mark/markanvandning/markanvandningen-i-sverige/pong/tabell-och-diagram/markanvandningen-i-sverige/, 6 mars 2026.

SCB, *Marken i Sverige*, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/marken-i-sverige/, 6 mars 2026.

Shoesmith, Emily; Surr, Claire & Charura, Divine, "What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people with dementia? A qualitative exploration", *Dementia: the international journal of social research and practice*, 20(4), 2020, sid. 1-27, DOI:10.1177/1471301220938481.

SLU Artdatabanken - Artfakta*, Björkar Betula*, https://artfakta.se/taxa/1006019/information, 1 maj 2026.

SLU Artdatabanken - Artfakta*, Päronsläktet Pyrus*, https://artfakta.se/taxa/1006578/taxonomi, 1 maj 2026.

Stanzani Maserati, Michelangelo; Matacena, Corrado; Sambati, Luisa; Oppi, Frederico; Poda, Roberto; De Matteis, Maddalena & Gallassi, Roberto, "The Tree-Drawing Test (Koch's Baum Test): A Useful Aid to Diagnose Cognitive Impairment", *Behavioural Neurology*, 2015, sid. 1-6, DOI:10.1155/2015/534681.

Svenskt Demenscentrum, *Sjukdomens faser*, https://demenscentrum.se/fakta-om-demens/demenssjukdomar/alzheimers-sjukdom/sjukdomens-faser, 2 april 2026.

Sveriges Riksdag, *Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor*, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460/, 16 februari 2026.

Swedish FTD Initiative, *Vad är FTD?*, https://frontallobsdemens.se/att-leva-med-frontlobsdemens/vad-ar-ftd/, 26 februari 2026.

Säfström, Carl Anders, *Skillnadens pedagogik*, Lund: Studentlitteratur, 2005.

Säljö, Roger, "Kontext och mänskliga samspel - Ett sociokulturellt perspektiv på lärande", i *Utbildning & Demokrati*, 20(3), 2011, sid. 67-85.

Vetenskapsrådet, *God forskningssed 2024*, https://www.vr.se/download/18.4c9f221a191e4edf9053a474/1727853946433/God%20forskningssed%20VR%202024.pdf, 2 juni 2026.

Vårdföretagarna, *Kreativt skapande lugnar och väcker minnen för demenssjuka på Villa Basilika*, https://www.vardforetagarna.se/2019/12/kreativt-skapande-lugnar-och-vacker-minnen-for-demenssjuka-pa-villa-basilika/, 16 april 2026.

World Health Organization, *Arts and health*, https://www.who.int/initiatives/arts-and-health, 13 april 2026.

World Health Organization, *Dementia*, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia, 6 februari 2026.

Young, Rhea; Tischler, Victoria; Hulbert, Sarah & Camic, Paul M., "The impact of viewing and making art on verbal fluency and memory in people with dementia in an art gallery setting", *Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts*, 9(4), 2015, sid. 368–375, DOI:10.1037/aca0000030.

11.1 Bilagor

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Hej!

Jag heter Benjamin och går sista terminen på Konstfacks lärarutbildning, och ska nu genomföra mitt självständiga arbete i form av en forskningsstudie. Studiens syfte är att undersöka hur personer med demens upplever att få bidra till ett gemensamt konstprojekt, genom att måla/teckna egna träd. Ditt bidrag till studien kommer att sammanställas till ett större konstverk, och sedan ställas ut på Konstfack mellan den 13 maj - 24 maj.

Jag kommer att göra min undersökning på ditt boende, vilket innebär att jag dokumenterar arbetet på plats med hjälp av skriftliga analyser.

Med detta brev vill jag be om ditt samtycke för din medverkan. Dina anhöriga behöver inte skriva på, men du får gärna visa dem det här brevet. De, liksom du, får gärna höra av er om frågor uppstår. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så skriver du under bifogad blankett.

Några saker som kan vara bra att veta:

- Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (mer info finns på https://www.vr.se/). Detta innebär exempelvis att din och dina medboendes identitet inte får avslöjas, och konstverket som ställs ut kommer inte att innehålla några namn eller personuppgifter.
- Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, och inga register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet används enbart i min egen bearbetning och analys, samt sammanställs i en uppsats. Det dokumenterade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.
- Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.

Arbetet sker under handledning. Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller min handledare vid IBIS, Konstfack.

Vänliga hälsningar Benjamin

Benjamin Persson
Telefon:
Epost: Benjamin.Persson@student.konstfack.se

Ebba Christina Blåvarg (handledare)
Epost: Ebba.Christina.Blavarg@konstfack.se

Bilaga 1: Samtyckesblankett riktad åt deltagare (observera att jag justerat studiens syfte sedan blanketten skrevs)

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Hej!

Jag heter Benjamin och går sista terminen på Konstfacks lärarutbildning, och ska nu genomföra mitt självständiga arbete i form av en forskningsstudie. Studiens syfte är att undersöka hur personer med demens upplever att få bidra till ett gemensamt konstprojekt, genom att måla/teckna egna träd. Din närståendes bidrag kommer att sammanställas till ett större konstverk, och sedan ställas ut på Konstfack mellan den 13 maj - 24 maj.

Jag kommer att göra min undersökning på din närståendes boende, vilket innebär att jag dokumenterar arbetet på plats med hjälp av skriftliga analyser.

Med detta brev vill jag be om ditt samtycke för din närståendes medverkan. Du, liksom din närstående, får gärna höra av er om frågor uppstår. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker du till din närståendes medverkan i studien så skriver du under bifogad blankett.

Några saker som kan vara bra att veta:

- Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (mer info finns på https://www.vr.se/). Detta innebär exempelvis att din egen, din närståendes och de medboendes identitet inte får avslöjas, och konstverket som ställs ut kommer inte att innehålla några namn eller personuppgifter.
- Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, och inga register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet används enbart i min egen bearbetning och analys, samt sammanställs i en uppsats. Det dokumenterade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.
- Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.

Arbetet sker under handledning. Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller min handledare vid IBIS, Konstfack.

Vänliga hälsningar Benjamin

Benjamin Persson
Telefon:
Epost: Benjamin.Persson@student.konstfack.se

Ebba Christina Blåvarg (handledare)
Epost: Ebba.Christina.Blavarg@konstfack.se

Bilaga 2: Samtyckesblankett riktad åt deltagares anhöriga (observera att jag justerat studiens syfte sedan blanketten skrevs)

KONSTFACK
University of Arts, Crafts and Design

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Benjamin.
Om du inte samtycker är det bara att bortse från detta brev.

Ja, jag samtycker till att delta i Benjamins studie.

Din underskrift

……

Namnförtydligande (texta)

……

Datum för underskrift

……

Bilaga 3: Formulär för underskrift, på baksidan av båda samtyckesblanketterna